Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung von Krankenhausbehandlung 2

(Nur bei medizinischer Notwendigkeit zulässig)

☐ Belegarzt-behandlung

☐ Notfall

☐ Unfall, Unfallfolgen

☐ Versorgungs-leiden (BVG)

Nächsterreichbare, geeignete Krankenhäuser

Diagnose

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Bitte die Rückseite beachten!

Die Kostenverpflichtungserklärung gegenüber dem Krankenhaus bleibt der Krankenkasse vorbehalten; deshalb bitte diese Verordnung vor Aufsuchen des Krankenhauses der zuständigen Krankenkasse vorlegen.

Geschieht das nicht, so kann die Kostenübernahme durch die Krankenkasse abgelehnt werden; es sei denn, es liegt ein Notfall vor, und ein Leistungsanspruch besteht.

Vom Krankenhaus auszufüllen:

Krankenhausaufnahme

erfolgt(e) am _____

Freigabe 01.09.2014

Verbindliches Muster

Stempel des Krankenhauses und Unterschrift

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung von Krankenhausbehandlung 2

(Nur bei medizinischer Notwendigkeit zulässig)

☐ Belegarzt-behandlung ☐ Notfall

☐ Unfall, Unfallfolgen ☐ Versorgungs-leiden (BVG)

Nächsterreichbare, geeignete Krankenhäuser

Diagnose

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Bitte dem Patienten gesondert mitgeben!

Untersuchungsergebnisse

Bisherige Maßnahmen (z. B. Medikation)

Fragestellung/Hinweise (z. B. Allergie)

Mitgegebene Befunde

Ausfertigung für den Krankenhausarzt! Vertraulich!

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung von Krankenhausbehandlung 2

(Nur bei medizinischer Notwendigkeit zulässig)

☐ Belegarzt-behandlung ☐ Notfall

☐ Unfall, Unfallfolgen ☐ Versorgungs-leiden (BVG)

Nächsterreichbare, geeignete Krankenhäuser

Diagnose

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für den Krankenhausarzt! Vertraulich!

Untersuchungsergebnisse

Bisherige Maßnahmen (z. B. Medikation)

Fragestellung/Hinweise (z. B. Allergie)

Mitgegebene Befunde

Ausfertigung für den überweisenden Arzt

Freigabe 01.09.2014

Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung

3

Ausfertigung für die Krankenkasse

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Zum Nachweis gegenüber der Krankenkasse (Beantragung von Mutterschaftsgeld) bescheinige ich, dass die oben bezeichnete Versicherte voraussichtlich entbinden wird am T T M M J J

Die Bescheinigung erteile ich auf Grund der von mir vorgenommenen Untersuchung am T T M M J J

Ggf. besondere Feststellungen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Muster 3a (10.2014)

Vor der Weitergabe des Vordrucks an die Krankenkasse von der Versicherten auszufüllen.

Name, Vorname

Geburtsdatum T T M M J J

PLZ

Wohnort

Straße, Haus-Nr.

Kontoinhaber

IBAN

Geldinstitut

BIC

Angaben zum Beschäftigungsverhältnis

Ich bin derzeit

☐ beschäftigt, bei

gekündigt / befristet zum T T M M J J

Anschrift des Arbeitgebers

☐ selbständig

☐ arbeitslos

☐ Künstlerin / Publizistin

Erklärung:
Änderungen meiner Angaben teile ich der Krankenkasse umgehend mit. Sofern sich der mutmaßliche Entbindungstermin verschiebt, informiere ich meine Krankenkasse und meinen Arbeitgeber bzw. die Agentur für Arbeit.

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Unterschrift der Versicherten

Freigabe 01.09.2014

Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung

3

Ausfertigung für die Versicherte
(z.B. zur Vorlage beim Arbeitgeber)

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr.



Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

T T M M J J

Die Bescheinigung erteile ich auf Grund der von mir vorgenommenen Untersuchung am

T T M M J J

Ggf. besondere Feststellungen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Muster 3b (10.2014)

Freigabe 17.02.2020

Verordnung einer Krankenbeförderung 4

Zuzahlungspflicht

Zuzahlungsfrei

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

☐ Unfall, Unfallfolge

☐ Arbeitsunfall, Berufskrankheit

☐ Versorgungsleiden (z.B. BVG)

☐ Hinfahrt ☐ Rückfahrt

1. Grund der Beförderung

Genehmigungsfreie Fahrten

a) ☐ **voll-/teilstationäre Krankenhausbehandlung** ☐ **vor-/nachstationäre Behandlung**

b) ☐ **ambulante Behandlung** bei Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“, Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung, Pflegegrad 4 oder 5 **nur Taxi/Mietwagen** ***(Fahrt mit KTW ist unter f) zu verordnen)***

c) ☐ **anderer Grund**, z.B. Fahrten zu Hospizen:

Genehmigungspflichtige Fahrten zu ambulanten Behandlungen ***(vor Fahrtantritt der Krankenkasse vorzulegen)***

d) ☐ **hochfrequente Behandlung** Dialyse, onkol. Chemo- oder Strahlentherapie ☐ vergleichbarer Ausnahmefall ***(Begründung unter 4. erforderlich)***

e) ☐ **dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vergleichbar mit b) und Behandlungsdauer mindestens 6 Monate** ***(Begründung unter 4. erforderlich)***

f) ☐ **anderer Grund für Fahrt mit KTW**, z.B. fachgerechtes Lagern, Tragen, Heben erforderlich ***(Begründung unter 3. und ggf. 4. erforderlich)***

2. Behandlungstag/Behandlungsfrequenz und nächsterreichbare, geeignete Behandlungsstätte

vom/am T T M M J J / ☐ x pro Woche, bis voraussichtlich T T M M J J

Behandlungsstätte ***(Name, Ort)***

3. Art und Ausstattung der Beförderung

☐ Taxi/Mietwagen

☐ KTW, da medizinisch-fachliche Betreuung und/oder Einrichtung notwendig ist wegen

☐ Rollstuhl

☐ Tragestuhl

☐ liegend

☐ RTW ☐ NAW/NEF ☐ andere

4. Begründung/Sonstiges ***(z. B. Datum Aufnahme Krankenhaus, Gewicht bei Schwergewichttransport, Wartezeit, Gemeinschaftsfahrt, Ortsangabe, wenn Beförderung nicht von/zur Wohnung stattfindet)***

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Bitte die Fahrt immer durch den Versicherten quittieren lassen!

Bestätigung durch den Versicherten

Ich bestätige die Durchführung der im Folgenden aufgeführten Fahrten

Datum	Fahrtstrecke *(von ... nach)*	Hin-fahrt	Rück-fahrt	Unterschrift des Versicherten
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			
T T M M J J	von nach			

Bestätigung des Transporteurs

Die Krankenbeförderung wurde gemäß der obigen Bestätigung durchgeführt.

Gültiger Zuzahlungsbefreiungsausweis für den Zeitraum der Krankenbeförderung wurde vorgelegt

(Die Angabe ist nicht bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus erforderlich)

☐ nein ☐ ja

Datum T T M M J J

Freigabe 17.02.2020

Verbindliches Muster

Stempel/Unterschrift des Transporteurs

Abrechnungsdaten des Transporteurs

IK des Transporteurs

Belegnummer

Gesamt-Brutto ,

Rechnungsnummer

Zuzahlung ,

Positionsnummer | Anzahl | km

Positionsnummer | Anzahl | km

Freigabe 01.09.2014

Abrechnungsschein

05

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

☐ ambulante Behandlung ☐ bei belegärztlicher Behandlung ☐ Unfall, Unfallfolgen Quartal ☐ ☐☐

☐ Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie ☐ anerkannte Psychotherapie Geschlecht W M

Diagnosen / ggf. Abrechnungsbegründungen

Bei Psychotherapie: Datum des Anerkennungsbescheides T T M M J J

Tag	Mon.				Tag	Mon.			
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐

Mutmaßlicher Tag der Entbindung ☐☐ ☐☐ ☐☐

Stationäre belegärztliche Behandlung

	Tag	Monat		Tag	Monat
von	☐☐	☐☐	bis	☐☐	☐☐

Ich bin bei der oben genannten Krankenkasse versichert.

Datum Unterschrift

Verbindliches Muster

Stempel des Vertragsarztes/Therapeuten

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Freigabe 15.04.2019

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Überweisungsschein

06

Quartal Q J J

☐ Kurativ ☐ Präventiv ☐ Behandl. gemäß § 116b SGB V ☐ bei belegärztl. Behandlung

☐ Unfall Unfallfolgen

Datum der OP bei Leistungen nach Abschnitt 31.2 T T M M J J

Geschlecht ☐

Überweisung an

☐ Ausführung von Auftragsleistungen ☐ Konsiliar-untersuchung ☐ Mit-/Weiter-behandlung

AU bis T T M M J J

☐ eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V

Diagnose/Verdachtsdiagnose

Befund/Medikation

Auftrag

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Überweisung

7

Vor Aufnahme einer Psychotherapie zur Abklärung somatischer Ursachen

Diagnosen / Indikation zur Psychotherapie:

Information für den Arzt:

Der Konsiliarbericht ist dem Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichentherapeuten möglichst zeitnah, spätestens aber drei Wochen nach der Untersuchung zu übermitteln.

Ausstellungsdatum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel / Unterschrift des Therapeuten

Freigabe 01.09.2014

Sehhilfenverordnung 8

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

IK des Leistungserbringers

Rechnungsnummer

Belegnummer

Befund: Änderung um mindestens 0,5 Dioptrien ja nein

Wenn nein, wird eine Verbesserung der Sehschärfe um mindestens 20% erzielt? ja

Erstversorgung | Folgeversorgung

Unfall, Unfallfolgen | Versorgungsleiden (BVG)

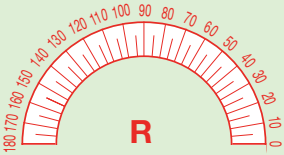
Sehbehinderung mindestens WHO 1

Reparatur | Ersatz

Menge und Art der Verordnung:

Diagnose/Begründung:

		Sphäre	Zylinder	Achse	Prisma	Basis	Scheitelabstand
F	R			°			
	L			°			
N	R			°			
	L			°			





Kostenrechnung des Leistungserbringers

10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer	Betrag Euro
Rechnungsbetrag	

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten (bei Erstversorgung oder Verlust der Sehhilfe)

Ich erkläre, ☐ dass ich bisher noch keine Sehhilfe gehabt habe

☐ dass meine bisherige Sehhilfe verlorengegangen ist

Datum	Unterschrift des Versicherten

Entscheidung der Krankenkasse

Die Kosten werden übernommen

☐ in Höhe des geltenden Festbetrages

☐ in Höhe von Euro

Datum

Stempel der Krankenkasse und Unterschrift

Verbindliches Muster

Empfangsbestätigung

_____ Glas / Gläser bzw. Kontaktlinsen

Sonstiges: _____

Datum	Unterschrift des Empfängers (Vor- und Zuname)

Bescheinigung des Leistungserbringers

Die Sehhilfe wurde gemäß vorstehender Empfangsbestätigung abgegeben und angepasst.
Ich versichere, dass die gelieferte Sehhilfe der Verordnung entspricht.

Datum

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers

Freigabe 01.09.2014

Zur Beachtung für den Versicherten

Diese Verordnung ist kein Gutschein für einen bestimmten Betrag.
Die **Lieferung anderer Ware** anstelle der verordneten Sehhilfen ist **nicht gestattet.**

Freigabe 01.09.2014

Verordnung von vergrößernden Sehhilfen

8A

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

IK des Leistungserbringers

Rechnungsnummer

Belegnummer

Befund:

Erst-versorgung ☐ Folge-versorgung ☐

Bestkorrigierter Fernvisus rechts ____ Bestkorrigierter Fernvisus links ____

Unfall, Unfallfolgen ☐ Versorgungs-leiden (BVG) ☐

Sehbehinderung mindestens WHO 1 ☐ mit Brille ☐ Kontaktlinsen ☐

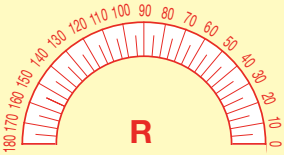
Vergrößerungs-bedarf ☐ fach

Reparatur ☐ Ersatz ☐

Menge und Art der Verordnung:

Diagnose/Begründung:

		Sphäre	Zylinder	Achse	Prisma	Basis	Scheitel-abstand
F	R			°			
	L			°			
N	R			°			
	L			°			





Kostenrechnung des Leistungserbringers

10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer	Betrag Euro
Rechnungsbetrag	

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten (bei Erstversorgung oder Verlust der Sehhilfe)

Ich erkläre, ☐ dass ich bisher noch keine Sehhilfe gehabt habe

☐ dass meine bisherige Sehhilfe verlorengegangen ist

Datum	Unterschrift des Versicherten

Entscheidung der Krankenkasse

Die Kosten werden übernommen

☐ in Höhe des geltenden Festbetrages

☐ in Höhe von Euro

Datum

Stempel der Krankenkasse und Unterschrift

Empfangsbestätigung

_____ vergrößernde Sehhilfen

Datum	Unterschrift des Empfängers (Vor- und Zuname)

Bescheinigung des Leistungserbringers

Die vergrößernde Sehhilfe wurde gemäß vorstehender Empfangsbestätigung abgegeben und angepasst.
Ich versichere, dass die gelieferte vergrößernde Sehhilfe der Verordnung entspricht.

Datum

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers

Verbindliches Muster

Freigabe 01.09.2014

Zur Beachtung für den Versicherten

Diese Verordnung ist kein Gutschein für einen bestimmten Betrag.
Die **Lieferung anderer Ware** anstelle der verordneten vergrößernden Sehhilfen ist **nicht gestattet.**

~~Freigabe 15.08.2025~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Bescheinigung einer Fehlgeburt, Frühgeburt oder Behinderung des Kindes

9

1. Fehlgeburt am T T M M J J

Die oben bezeichnete Versicherte befand sich mindestens in der

☐ 13. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 2 Wochen)

☐ 17. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 6 Wochen)

☐ 20. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 8 Wochen)

(Bitte auch Rückseite ausfüllen!)

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

2. Frühgeburt am T T M M J J

☐ a) Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm

☐ b) Geburtsgewicht ab 2.500 Gramm, es besteht jedoch ein wesentlich erweiterter Pflegebedarf wegen nicht voll ausgebildeter Reifezeichen oder verfrühter Beendigung der Schwangerschaft

3. Behinderung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX

☐ Bei dem Kind liegt eine Behinderung vor

(Bitte auch Rückseite ausfüllen!)

Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse

Hiermit beantrage ich die Auszahlung von Mutterschaftsgeld bzw. die Verlängerung der Schutzfrist aufgrund der Behinderung meines Kindes

Name

Vorname

Geburtsdatum

T T M M J J

Versichertennummer

IBAN

BIC

Kontoinhaber (falls abweichend von antragstellender Person)

Angaben zum Beschäftigungsverhältnis

Ich bin derzeit

☐ beschäftigt

Arbeitgeber

gekündigt/befristet zum

T T M M J J

Anschrift des Arbeitgebers

☐ arbeitslos

☐ selbständig

☐ Künstlerin/Publizistin

Erklärung

Im Fall einer Fehlgeburt erkläre ich, dass ich meinen Arbeitgeber bzw. die Bundesagentur für Arbeit über die Fehlgeburt informiert habe. Wenn ich meine Beschäftigung/Tätigkeit vor dem Ende der Schutzfrist wieder aufnehme, teile ich dies der Krankenkasse umgehend mit.

Datum

T T M M J J

~~Freigabe 15.08.2025~~

Verbindliches Muster

Unterschrift der Versicherten

Freigabe 15.08.2025

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | 

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Bescheinigung einer Fehlgeburt

9

1. Fehlgeburt am T T M M J J

Die oben bezeichnete Versicherte befand sich mindestens in der

☐ 13. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 2 Wochen)

☐ 17. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 6 Wochen)

☐ 20. Schwangerschaftswoche (Schutzfrist 8 Wochen)

Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

~~Freigabe 15.11.2023~~

Überweisungsschein für in-vitro-diagnostische Auftragsleistungen

10

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Eintrag nur bei Weiterüberweisung!

Betriebsstätten-Nr. des Erstveranlassers | Arzt-Nr. des Erstveranlassers

☐ Kurativ ☐ Präventiv ☐ bei belegärztl. Behandlung ☐ Unfall, Unfallfolgen

Auftragsnummer des Labors

Hier bitte sorgfältig Barcode-Etikett einkleben!

Knappschafts-kennziffer

Quartal Q J J

Geschlecht

☐ Kontrolluntersuchung bekannte Infektion

eingeschränkter Leistungsanspruch

☐ SER ☐ gemäß § 16 Abs. 3a SGB V

Abnahmedatum T T M M J J

Abnahmezeit h h m m

☐ Empfängnisregelung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch

SSW

☐ **Befund eilt,** Übermittlung an ☐ Telefon ☐ Fax Nr. _____

Diagnose/Verdachtsdiagnose

Befund/Medikation

Auftrag

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift überw. Arzt

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

~~Freigabe 06.05.2020~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Verbindliches Muster

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Anforderungsschein für Laboratoriums-untersuchungen bei Laborgemeinschaften

10A

☐ Kurativ ☐ Präventiv ☐ bei belegärztl. Behandlung ☐ Unfall, Unfallfolgen

Knappschafts-kennziffer | Geschlecht | SSW

Hier bitte sorgfältig Barcode-Etikett einkleben !

Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen

Abnahmedatum T T M M J J

Abnahmezeit h h m m

⬭ Befund eilt	1	**Serum / Plasma / Vollblut**						**Urin**	
EDTA-Blut		⬭ alkalische Phosphatase	13	⬭ Gamma GT	27	⬭ LDL-Cholesterin	42	⬭ Status	55
⬭ großes Blutbild	2	⬭ Amylase	14	⬭ Glukose	28	⬭ Lipase	43	⬭ Mikroalbumin	56
⬭ kleines Blutbild	3	⬭ ASL	15	⬭ GOT / ASAT	29	⬭ Natrium	44	⬭ Glukose	58
⬭ HbA1c	4	⬭ Bilirubin direkt	16	⬭ GPT / ALAT	30	⬭ OP-Vorbereitung (32125)	45	⬭ Sediment	60
⬭ Retikulozyten	5	⬭ Bilirubin gesamt	17	⬭ Harnsäure	31			**Citrat-Blut**	
⬭ Blutsenkung	6	⬭ Calcium	18	⬭ Harnstoff	32	⬭ Phosphat, anorg.	46	⬭ Quick	8
Gesundheits-untersuchungen		⬭ Cholesterin	19	⬭ HDL-Cholesterin	34	⬭ Transferrin	47	⬭ Quick unter Marcumar-Therapie	9
⬭ Harnstreifentest (32880)	62	⬭ Cholinesterase	20	⬭ IgA	35	⬭ Triglyceride	48		
⬭ Nüchternplasma-glukose (32881)	63	⬭ CK	21	⬭ IgG	36	⬭ TSH	49	⬭ Thrombinzeit	10
⬭ Lipidprofil (32882)	64	⬭ CRP	23	⬭ IgM	37			⬭ PTT	11
		⬭ Eisen	24	⬭ Kalium	38	**Glukose-Profil**			
		⬭ Eiweiß Elektrophorese	25	⬭ Kreatinin	39	⬭ Glukose 1	51	⬭ Sonstiges	61
				⬭ Kreatinin Clearance	40	⬭ Glukose 2	52		
						⬭ Glukose 3	53		
		⬭ Eiweiß gesamt	26	⬭ LDH	41	⬭ Glukose 4	54		

Bericht für den Medizinischen Dienst

Der behandelnde Arzt wird gebeten, den nachstehenden Berichtsvordruck auszufüllen und Röntgen-, Labor- und andere Spezialbefunde sowie Krankenhausberichte und dergleichen dem Medizinischen Dienst zur Verfügung zu stellen. Dieser Vordruck ist dann nicht auszufüllen, wenn spätestens am Tage der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst die Arbeitsunfähigkeit beendet ist.

Datum der letzten Untersuchung | T | T | M | M | J | J |

Diagnose _____

_____

Befunde _____

_____

_____

_____

Mitbehandlung ☐ nein ☐ ja, im Fachbereich _____

Es droht ☐ eine Verschlimmerung des Leidens oder ☐ Behinderung

Besondere Hinweise _____

_____

Patientin / Patient kann den Medizinischen Dienst nicht aufsuchen, weil _____

_____

_____

Eine Begutachtung ist voraussichtlich nach ☐☐ Tagen / Wochen möglich. ***(Nichtzutreffendes streichen)***

Arbeitsfähig ab | T | T | M | M | J | J |

Voraussichtlich arbeitsfähig ab | T | T | M | M | J | J |

Folgendes ist mit der Bitte um Rückgabe beigefügt:

☐ Röntgenbefund ☐ Ultraschallbefund ☐ EKG-befund

☐ Laborbefund ☐ Arzt- oder Krankenhausbericht

Sonstiges _____

Für den Bericht des Arztes ist die Nr. 01621 EBM berechnungsfähig

Ausstellungsdatum | T | T | M | M | J | J |

~~**Freigabe 31.10.2014**~~

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 15.11.2023~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung häuslicher Krankenpflege 12

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen
(vgl. auch Leistungsverzeichnis HKP-Richtlinie)

☐ Erstverordnung ☐ Folgeverordnung ☐ Unfall ☐ SER

Nur bei ärztlicher Festlegung von Häufigkeit und Dauer

vom T T M M J J bis T T M M J J

Behandlungspflege

Häufigkeit/Dauer von Pflegefachkraft

Dauer nur anzugeben bei Abweichung von Dauer der gesamten Verordnung

	Häufigkeit			Dauer (TTMM)	
	tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis
☐ Herrichten der Medikamentenbox					
☐ Medikamentengabe					
☐ Injektionen ☐ herrichten ☐ intramuskulär ☐ subkutan					

Medikamentengabe, ***Präparate***

Blutzuckermessung

☐ Erst- oder Neueinstellung ***(max. 4 Wochen und max. 3x täglich)*** ☐ bei intensivierter Insulintherapie

Kompressionsbehandlung ☐ rechts ☐ links ☐ beidseits

☐ Kompressionsstrümpfe anziehen ☐ Kompressionsstrümpfe ausziehen

☐ Kompressionsverbände anlegen ☐ Kompressionsverbände abnehmen

☐ stützende und stabilisierende Verbände, Art

Wundversorgung

Wundart

Lokalisation | aktuelle Größe ***(Länge, Breite, Tiefe)*** | aktueller Grad

Präparate, Verbandmaterialien

☐ Wundversorgung akut

☐ Wundversorgung chronisch

Sonstige Maßnahmen der Behandlungspflege

Anleitung zur Behandlungspflege ***für Patient/Angehörige (z.B. Injektionen, Wundbehandlung)*** | Anzahl

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung

☐ Unterstützungspflege nach § 37 (1a) SGB V

☐ Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 (1) SGB V

	Häufigkeit			Dauer	
	tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis
☐ Grundpflege					
☐ hauswirtschaftliche Versorgung					

Weitere Hinweise

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für die Krankenkasse

Freigabe 15.11.2023

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

Antrag des Versicherten auf Genehmigung häuslicher Krankenpflege

Ich beantrage häusliche Krankenpflege für die Zeit vom T T M M J J bis T T M M J J

- ☐ in meinem Haushalt
- ☐ im Haushalt einer sonstigen Person
- ☐ in einer Schule, Kindergarten
- ☐ in einer betreuten Wohnform
- ☐ in einer Werkstatt für behinderte Menschen
- ☐ in einer Wohngemeinschaft
- ☐ in einer sonstigen Einrichtung

Name

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

☐ Folgende verordnete Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege können durch eine im Haushalt lebende Person erbracht werden

☐ Die verordneten Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege können durch eine im Haushalt lebende Person **nicht** erbracht werden

☐ Bitte senden Sie mir Informationen über zugelassene Pflegedienste

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten oder des gesetzlichen Vertreters

Angaben des Pflegedienstes *(soweit vom Versicherten ein Pflegedienst schon beauftragt worden ist)*

Folgende Leistungen sollen erbracht werden für die Zeit vom T T M M J J bis T T M M J J

Leistung	Häufigkeit tgl.	Häufigkeit wtl.	Häufigkeit mtl.	Dauer vom	Dauer bis

Die Pflege wird durchgeführt von einem zugelassenen Pflegedienst *(Vertragspartner gem. § 132a Abs. 4 SGB V)*

Name des Pflegedienstes

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

Institutionskennzeichen Pflegedienst

Beschäftigtennummer der Pflegefachkraft

Ansprechpartner in dem Pflegedienst (Name)

Telefonnummer des Pflegedienstes

Fax-Nr. des Pflegedienstes

E-Mail-Adresse des Pflegedienstes

Datum T T M M J J

Stempel / Unterschrift des Pflegedienstes

~~Freigabe 15.11.2023~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung häuslicher Krankenpflege 12

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen
(vgl. auch Leistungsverzeichnis HKP-Richtlinie)

Nur bei ärztlicher Festlegung von Häufigkeit und Dauer

☐ Erstverordnung ☐ Folgeverordnung ☐ Unfall ☐ SER

vom T T M M J J bis T T M M J J

Behandlungspflege

Häufigkeit/Dauer von Pflegefachkraft

Dauer nur anzugeben bei Abweichung von Dauer der gesamten Verordnung

Häufigkeit			Dauer (TTMM)	
tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis

Medikamentengabe, ***Präparate***

☐ Herrichten der Medikamentenbox

☐ Medikamentengabe

☐ Injektionen ☐ herrichten ☐ intramuskulär ☐ subkutan

Blutzuckermessung

☐ Erst- oder Neueinstellung ***(max. 4 Wochen und max. 3x täglich)*** ☐ bei intensivierter Insulintherapie

Kompressionsbehandlung ☐ rechts ☐ links ☐ beidseits

☐ Kompressionsstrümpfe anziehen ☐ Kompressionsstrümpfe ausziehen

☐ Kompressionsverbände anlegen ☐ Kompressionsverbände abnehmen

☐ stützende und stabilisierende Verbände, Art

Wundversorgung

Wundart

Lokalisation | aktuelle Größe ***(Länge, Breite, Tiefe)*** | aktueller Grad

Präparate, Verbandmaterialien

☐ Wundversorgung akut

☐ Wundversorgung chronisch

Sonstige Maßnahmen der Behandlungspflege

Anleitung zur Behandlungspflege ***für Patient/Angehörige (z.B. Injektionen, Wundbehandlung)*** | Anzahl

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung

☐ Unterstützungspflege nach § 37 (1a) SGB V

☐ Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 (1) SGB V

☐ Grundpflege

☐ hauswirtschaftliche Versorgung

Häufigkeit			Dauer	
tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis

Weitere Hinweise

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für den Pflegedienst

~~Freigabe 15.11.2023~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung häuslicher Krankenpflege 12

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen
(vgl. auch Leistungsverzeichnis HKP-Richtlinie)

Nur bei ärztlicher Festlegung von Häufigkeit und Dauer

☐ Erstverordnung ☐ Folgeverordnung ☐ Unfall ☐ SER

vom T T M M J J bis T T M M J J

Behandlungspflege

Häufigkeit/Dauer von Pflegefachkraft

Dauer nur anzugeben bei Abweichung von Dauer der gesamten Verordnung

Häufigkeit			Dauer (TTMM)	
tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis

Medikamentengabe, *Präparate*

☐ Herrichten der Medikamentenbox

☐ Medikamentengabe

☐ Injektionen ☐ herrichten ☐ intramuskulär ☐ subkutan

Blutzuckermessung

☐ Erst- oder Neueinstellung ***(max. 4 Wochen und max. 3x täglich)*** ☐ bei intensivierter Insulintherapie

Kompressionsbehandlung ☐ rechts ☐ links ☐ beidseits

☐ Kompressionsstrümpfe anziehen ☐ Kompressionsstrümpfe ausziehen

☐ Kompressionsverbände anlegen ☐ Kompressionsverbände abnehmen

☐ stützende und stabilisierende Verbände, Art

Wundversorgung

Wundart

Lokalisation | aktuelle Größe ***(Länge, Breite, Tiefe)*** | aktueller Grad

Präparate, Verbandmaterialien

☐ Wundversorgung akut

☐ Wundversorgung chronisch

Sonstige Maßnahmen der Behandlungspflege

Anleitung zur Behandlungspflege ***für Patient/Angehörige (z.B. Injektionen, Wundbehandlung)*** Anzahl

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung

☐ Unterstützungspflege nach § 37 (1a) SGB V

☐ Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 (1) SGB V

☐ Grundpflege

☐ hauswirtschaftliche Versorgung

Häufigkeit			Dauer	
tgl.	wtl.	mtl.	vom	bis

Weitere Hinweise

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für den Vertragsarzt

~~Freigabe 08.01.2020~~

Heilmittelverordnung 13

Zuzahlungsfrei

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Zuzahlungspflicht

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Unfallfolgen

BVG

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

- ☐ Physiotherapie
- ☐ Podologische Therapie
- ☐ Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie
- ☐ Ergotherapie
- ☐ Ernährungstherapie

Behandlungsrelevante Diagnose(n)
ICD-10 - Code

Diagnosegruppe

Leitsymptomatik gemäß Heilmittelkatalog ☐ **a** ☐ **b** ☐ **c**

patientenindividuelle Leitsymptomatik ☐

Leitsymptomatik ***(patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)***

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Heilmittel	Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

☐ **Therapiebericht**

Hausbesuch ☐ ja ☐ nein

Therapiefrequenz

☐ **Dringlicher Behandlungsbedarf** innerhalb von 14 Tagen

ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und Hinweise

IK des Leistungserbringers

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Empfangsbestätigung durch den Versicherten

Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Behandlungen erhalten zu haben

	Datum	Maßnahmen *(erhaltene Heilmittel, ggf. auch Hausbesuche)*	Leistungserbringer	Unterschrift des Versicherten
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19			**Freigabe 08.01.2020**	
20				

Abrechnungsdaten des Heilmittelerbringers

Rechnungsnummer

IK des Leistungserbringers

Belegnummer

Behandlungsabbruch

T T M M J J

Nach Rücksprache mit dem Arzt

☐ Abweichung von der Frequenz

Änderung in

☐ Gruppentherapie ☐ Einzeltherapie

Begründung

Verbindliches Muster

Stempel/Unterschrift des Leistungserbringers

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

IK des Leistungserbringers

Ohrenärztliche Verordnung einer Hörhilfe

15

Rechnungsnummer

Belegnummer

Der Anspruchsberechtigte war schon Träger eines Gerätes ja ☐ nein ☐

Falls ja,
warum entspricht das bisher getragene Gerät nicht mehr den Anforderungen?

Ohrbefund

Rechts

Gehörgang normal ☐ operativ erweitert ☐ eng ☐

Trommelfell intakt ☐ durchlöchert ☐ feucht ☐

Ohrbefund

Links

Gehörgang normal ☐ operativ erweitert ☐ eng ☐

Trommelfell intakt ☐ durchlöchert ☐ feucht ☐

Frequenz in kHz

0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10

Hörverlust in dB: -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

R

Unbehaglichkeitsschwelle bitte eintragen

Weber bei 500 Hz

R | med. | L

Geräusch

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | dB

Frequenz in kHz

0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10

Hörverlust in dB: -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

L

Unbehaglichkeitsschwelle bitte eintragen

Verständlichkeit in %

0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100

Sprachschallpegel in dB: 5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110

R

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Hörverlust (dB)

Diskriminationsverlust in %

Impedanz

R	Sondenohr	L
	MO-Druck mm H_2O	

dB HL	dB SL	Stapedius-Reflex	dB HL	dB SL
		0,5 kHz		
		1 kHz		
		2 kHz		
		4 kHz		

R	Fl. Spr. (Zahlen)	L
	Um. Spr. (Zahlen)	

Verständlichkeit in %

0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100

Sprachschallpegel in dB: 5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110

L

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Hörverlust (dB)

Diskriminationsverlust in %

Diagnose

Hörhilfe ist notwendig rechts ☐ links ☐ beiderseits ☐

Tinnitusmasker / Tinnitusinstrument notwendig

rechts _____ kHz verdeckbar dB _____ **links** _____ kHz verdeckbar dB _____

Die Schwerhörigkeit ist Folge von Unfall, Unfallfolgen ☐ Versorgungsleiden (BVG) ☐

Die audiometrischen Untersuchungen wurden von mir bzw. unter meiner Verantwortung vorgenommen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Wichtiger Hinweis für den Versicherten

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Hörgeräte/Tinnitusmasker/Tinnitusinstrumente bis zu einem Festbetrag

Kostenvoranschlag des Hörgeräteakustikers

Hörvermögen über Lautsprecher (65 dB bei 1 m Abstand ohne Hörgerät)

a) mit Einsilbern _____ % oder

b) mit Mehrsilbern _____ % (entsprechend DIN 45621) oder

c) mit Sätzen _____ % (Marburger Satztest nach Niemeyer)

Vergleich verschiedener Hörgeräte über Lautsprecher (65 dB bei 1 m Abstand)

	Nr. der Gruppe			Fabrikat Typ	Hilfsmittelpositionsnummer	Verstanden
	Zahlen	Wörter	Sätze			
A						
B						
C						
D						

Nach den durchgeführten Hörproben schlage ich unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit folgende Versorgung vor

Gerät _____ Positionsnummer _____

Begründung _____

Gesamtpreis _____ Euro

Ausgestellt am

Stempel und Unterschrift

Kostenvoranschlag für

Tinnitusmasker ☐ Tinnitusinstrument ☐

Gesamtpreis _____ Euro

Ausgestellt am

Stempel und Unterschrift

Ärztliche Bescheinigung

☐ Ich habe mich davon überzeugt, dass durch die vorgeschlagene Hörhilfe eine ausreichende Hörverbesserung erzielt wird. Das vorgeschlagene Gerät ist zweckmäßig

☐ Ich habe mich davon überzeugt, dass der Tinnitusmasker/das Tinnitusinstrument ausreichend zweckmäßig ist

Ausgestellt am

Vertragsarztstempel/Unterschrift des Arztes

Leistung der Krankenkasse

Die Krankenkasse übernimmt _____ Euro

Die Zahlung erfolgt nur auf Grund einer Rechnung

Ausgestellt am

Stempel und Unterschrift

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, am _____

erhalten zu haben

die verordnete Hörhilfe ☐

den verordneten Tinnitusmasker/ das verordnete Tinnitusinstrument ☐

Unterschrift des Empfängers

Freigabe 01.09.2014

Raum für interne Vermerke der Krankenkasse

Verbindliches Muster

Freigabe 01.09.2014

Gebühr frei

Geb.-pfl.

noctu

Sonstige

Unfall

Arbeits-unfall

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Verbindliches Muster

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

BVG	Hilfs-mittel	Impf-stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
6	7	8	9		

Zuzahlung | Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe
1. Verordnung		
2. Verordnung		
3. Verordnung		

Vertragsarztstempel

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

aut idem

aut idem

aut idem

6664

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes

Muster 16 (10.2014)

Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Empfangsbestätigung für Hilfsmittel

Nr.	Datum	Unterschrift des Empfängers
1		
2		
3		

Stempel der Apotheke / des Lieferanten

Vermerke der Krankenkasse

Verbindliches Muster

Freigabe 01.09.2014

Wird das Arzneimittel innerhalb der Zeiten gemäß § 6 Arzneimittelpreisverordnung (Notdienst) abgeholt, so hat der Patient eine Gebühr (2,50 Euro) zu zahlen, sofern der Arzt nicht einen entsprechenden Vermerk (noctu) anbringt.

Freigabe 01.09.2014

Notfall-/Vertretungsschein

19

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

☐ ärztlicher Notfalldienst ☐ Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung ☐ Notfall Quartal ☐ ☐☐

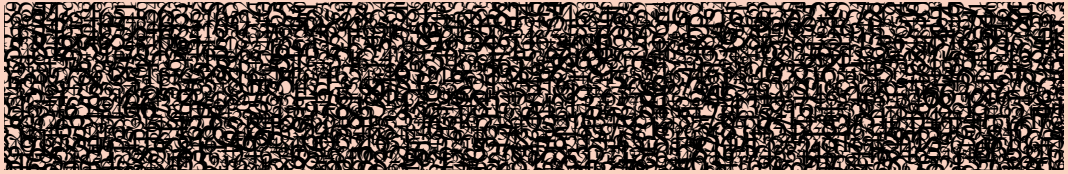
☐ Unfall Unfallfolgen Geschlecht W M

Diagnosen / ggf. Abrechnungsbegründungen

Arbeitsunfähigkeit bescheinigt bis

Teil b erhält weiterbehandelnder Arzt:

Befunde/Therapie *bitte auf Teil b eintragen!*



Tag	Mon.			Tag	Mon.		

Ich bin bei der oben genannten Krankenkasse versichert.

Datum Unterschrift des Versicherten

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel

Freigabe 01.09.2014

Notfall-/Vertretungsschein

19

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

☐ ärztlicher Notfalldienst ☐ Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung ☐ Notfall Quartal ☐☐

☐ Unfall Unfallfolgen Geschlecht W M

Diagnosen / ggf. Abrechnungsbegründungen

Arbeitsunfähigkeit bescheinigt bis ☐☐ ☐☐ ☐☐

Teil b erhält weiterbehandelnder Arzt:

Befunde/Therapie

Tag	Mon.			Tag	Mon.		
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐
☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐

Ich bin bei der oben genannten Krankenkasse versichert.

Datum _____ Unterschrift des Versicherten _____

Mitteilung für den weiterbehandelnden Arzt

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Notfall-/Vertretungsschein

19

☐ ärztlicher Notfalldienst ☐ Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung ☐ Notfall Quartal

☐ Unfall Unfallfolgen Geschlecht W M

Diagnosen / ggf. Abrechnungsbegründungen

Arbeitsunfähigkeit bescheinigt bis

Teil b erhält weiterbehandelnder Arzt:

Befunde/Therapie

Tag Mon. Tag Mon.

Ich bin bei der oben genannten Krankenkasse versichert.

Datum Unterschrift des Versicherten

Zum Verbleib beim vertretenden Arzt

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel

Muster 19c (10.2014)

~~Freigabe 15.10.2018~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr.

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)

20

zuletzt ausgeübte Tätigkeit

Stunden täglich

Durch eine stufenweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit kann der o. g. Versicherte nach aktueller Betrachtung stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden. Nach meiner ärztlichen Beurteilung empfehle ich mit Einverständnis des Versicherten und nach dessen Rücksprache mit dem Arbeitgeber folgenden Ablauf für die stufenweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit

vom	bis	Art der Tätigkeit (ggf. Einschränkungen)	Stunden täglich
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		

Für die Erstellung des ärztlichen Wiedereingliederungsplanes ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten

Mit dem vorgeschlagenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden. Falls nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, kann nach Absprache mit dem behandelnden Arzt eine Anpassung der Belastungseinschränkungen vorgenommen oder die Wiedereingliederung abgebrochen werden.

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten

Erklärung des Arbeitgebers

Mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden

☐ ja

☐ nur unter folgenden Voraussetzungen

☐ nein

Für die geleisteten Stunden wird ein (Teil-)Arbeitsentgelt gezahlt

☐ ja

☐ nein

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Ausfertigung für den Arbeitgeber

Freigabe 15.10.2018

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)

20

zuletzt ausgeübte Tätigkeit

Stunden täglich

Durch eine stufenweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit kann der o. g. Versicherte nach aktueller Betrachtung stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden. Nach meiner ärztlichen Beurteilung empfehle ich mit Einverständnis des Versicherten und nach dessen Rücksprache mit dem Arbeitgeber folgenden Ablauf für die stufenweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit

vom	bis	Art der Tätigkeit (ggf. Einschränkungen)	Stunden täglich
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		

Für die Erstellung des ärztlichen Wiedereingliederungsplanes ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten

Mit dem vorgeschlagenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden. Falls nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, kann nach Absprache mit dem behandelnden Arzt eine Anpassung der Belastungseinschränkungen vorgenommen oder die Wiedereingliederung abgebrochen werden.

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten

Erklärung des Arbeitgebers

Mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden

☐ ja

☐ nur unter folgenden Voraussetzungen

☐ nein

Für die geleisteten Stunden wird ein (Teil-)Arbeitsentgelt gezahlt

☐ ja

☐ nein

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Ausfertigung für die Krankenkasse

~~Freigabe 15.10.2018~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)

20

zuletzt ausgeübte Tätigkeit

Stunden täglich

Durch eine stufenweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit kann der o. g. Versicherte nach aktueller Betrachtung stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden. Nach meiner ärztlichen Beurteilung empfehle ich mit Einverständnis des Versicherten und nach dessen Rücksprache mit dem Arbeitgeber folgenden Ablauf für die stufenweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit

vom	bis	Art der Tätigkeit (ggf. Einschränkungen)	Stunden täglich
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		

Für die Erstellung des ärztlichen Wiedereingliederungsplanes ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten

Mit dem vorgeschlagenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden. Falls nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, kann nach Absprache mit dem behandelnden Arzt eine Anpassung der Belastungseinschränkungen vorgenommen oder die Wiedereingliederung abgebrochen werden.

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten

Erklärung des Arbeitgebers

Mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden

☐ ja

☐ nur unter folgenden Voraussetzungen

☐ nein

Für die geleisteten Stunden wird ein (Teil-)Arbeitsentgelt gezahlt

☐ ja

☐ nein

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Ausfertigung für den Versicherten

~~Freigabe 15.10.2018~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)

20

zuletzt ausgeübte Tätigkeit

Stunden täglich

Durch eine stufenweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit kann der o. g. Versicherte nach aktueller Betrachtung stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden. Nach meiner ärztlichen Beurteilung empfehle ich mit Einverständnis des Versicherten und nach dessen Rücksprache mit dem Arbeitgeber folgenden Ablauf für die stufenweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit

vom	bis	Art der Tätigkeit (ggf. Einschränkungen)	Stunden täglich
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		
T T M M J J	T T M M J J		

Für die Erstellung des ärztlichen Wiedereingliederungsplanes ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Erklärung des Versicherten

Mit dem vorgeschlagenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden. Falls nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, kann nach Absprache mit dem behandelnden Arzt eine Anpassung der Belastungseinschränkungen vorgenommen oder die Wiedereingliederung abgebrochen werden.

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten

Erklärung des Arbeitgebers

Mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan bin ich einverstanden

☐ ja

☐ nur unter folgenden Voraussetzungen

☐ nein

Für die geleisteten Stunden wird ein (Teil-)Arbeitsentgelt gezahlt

☐ ja

☐ nein

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Ausfertigung für den Vertragsarzt

~~Freigabe 15.11.2023 V2~~

Ärztliche Bescheinigung 21 für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Das genannte Kind bedarf/bedurfte der Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege wegen Krankheit

vom T T M M J J

bis einschließlich T T M M J J

☐ Kita- oder Schulunfall / -folgen

☐ sonstiger Unfall, Unfallfolgen

☐ SER

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Antrag der/des Versicherten* für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes

Dieser Antrag ist bei der Krankenkasse der betreuenden Person zu stellen.

Name

Vorname

Geburtsdatum T T M M J J

Versichertennummer

Straße, Haus-Nr.

PLZ

Wohnort

IBAN

BIC

Kontoinhaber (falls abweichend von antragstellender Person)

Ich versichere, dass ich zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege des erkrankten Kindes der Arbeit ferngeblieben bin.

Ich bin Alleinerziehende(r) ☐ ja ☐ nein

Eine andere in meinem Haushalt lebende Person konnte die Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege des erkrankten Kindes nicht übernehmen.

Datum T T M M J J

Unterschrift der/des Versicherten

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Konsiliarbericht

22

vor Aufnahme einer Psychotherapie durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Auf Veranlassung von:

Arztnummer

Name des Therapeuten

Betriebsstättennummer

Es sollen ggf. Angaben zu folgenden Inhalten gemacht werden:
Aktuelle Beschwerden, Angaben zum psychischen und somatischen Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbesondere unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes), relevante anamnestische Daten im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden, medizinische Diagnosen, Differenzial- und Verdachtsdiagnosen, relevante Vor- und Parallelbehandlungen stat./amb. (z.B. laufende Medikation), ggf. Befunde, die eine ärztliche/ärztlich veranlasste Begleitbehandlung und/oder psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung erforderlich machen:

Psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Abklärung ist ☐ erforderlich ☐ nicht erforderlich ☐ erfolgt ☐ veranlasst

Sind ärztliche/ärztlich veranlasste Maßnahmen bzw. Untersuchungen notwendig bzw. veranlasst und ggf. welche?

☐ Aufgrund somatischer/psychiatrischer Befunde bestehen derzeit Kontraindikationen für eine psychotherapeutische Behandlung (Begründung s. o.)

☐ Ärztliche Mitbehandlung ist erforderlich
Art der Maßnahme:

Ausstellungsdatum

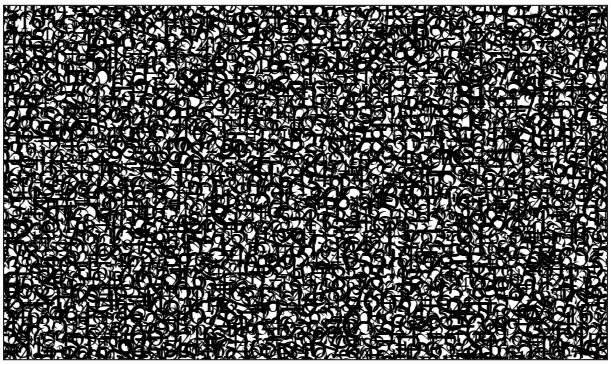
T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für diese Bescheinigung ist die Nr. 01612 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für den Therapeuten



Konsiliarbericht 22

vor Aufnahme einer Psychotherapie durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Auf Veranlassung von:

Arztnummer

Name des Therapeuten

Betriebsstättennummer

Chiffre | Anfangsbuchstabe des Familiennamens | T T M M J J Geburtsdatum | des Patienten

Es sollen ggf. Angaben zu folgenden Inhalten gemacht werden:
Aktuelle Beschwerden, Angaben zum psychischen und somatischen Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbesondere unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes), relevante anamnestische Daten im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden, medizinische Diagnosen, Differenzial- und Verdachtsdiagnosen, relevante Vor- und Parallelbehandlungen stat./amb. (z.B. laufende Medikation), ggf. Befunde, die eine ärztliche/ärztlich veranlasste Begleitbehandlung und/oder psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung erforderlich machen:

Psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Abklärung ist ☐ erforderlich ☐ nicht erforderlich ☐ erfolgt ☐ veranlasst

Sind ärztliche/ärztlich veranlasste Maßnahmen bzw. Untersuchungen notwendig bzw. veranlasst und ggf. welche?

☐ Aufgrund somatischer/psychiatrischer Befunde bestehen derzeit Kontraindikationen für eine psychotherapeutische Behandlung (Begründung s. o.)

☐ Ärztliche Mitbehandlung ist erforderlich
Art der Maßnahme:

~~Freigabe 01.09.2014~~

Verbindliches Muster

Ausstellungsdatum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für diese Bescheinigung ist die Nr. 01612 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für den Gutachter

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Konsiliarbericht

22

vor Aufnahme einer Psychotherapie durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Auf Veranlassung von:

Arztnummer

Name des Therapeuten

Betriebsstättennummer

Es sollen ggf. Angaben zu folgenden Inhalten gemacht werden:
Aktuelle Beschwerden, Angaben zum psychischen und somatischen Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbesondere unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes), relevante anamnestische Daten im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden, medizinische Diagnosen, Differenzial- und Verdachtsdiagnosen, relevante Vor- und Parallelbehandlungen stat./amb. (z.B. laufende Medikation), ggf. Befunde, die eine ärztliche/ärztlich veranlasste Begleitbehandlung und/oder psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung erforderlich machen:

Psychiatrische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Abklärung ist ☐ erforderlich ☐ nicht erforderlich ☐ erfolgt ☐ veranlasst

Sind ärztliche/ärztlich veranlasste Maßnahmen bzw. Untersuchungen notwendig bzw. veranlasst und ggf. welche?

☐ Aufgrund somatischer/psychiatrischer Befunde bestehen derzeit Kontraindikationen für eine psychotherapeutische Behandlung (Begründung s. o.)

☐ Ärztliche Mitbehandlung ist erforderlich
Art der Maßnahme:

Ausstellungsdatum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für diese Bescheinigung ist die Nr. 01612 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für den Vertragsarzt

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Konsiliarbericht

vor Aufnahme einer Psychotherapie durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

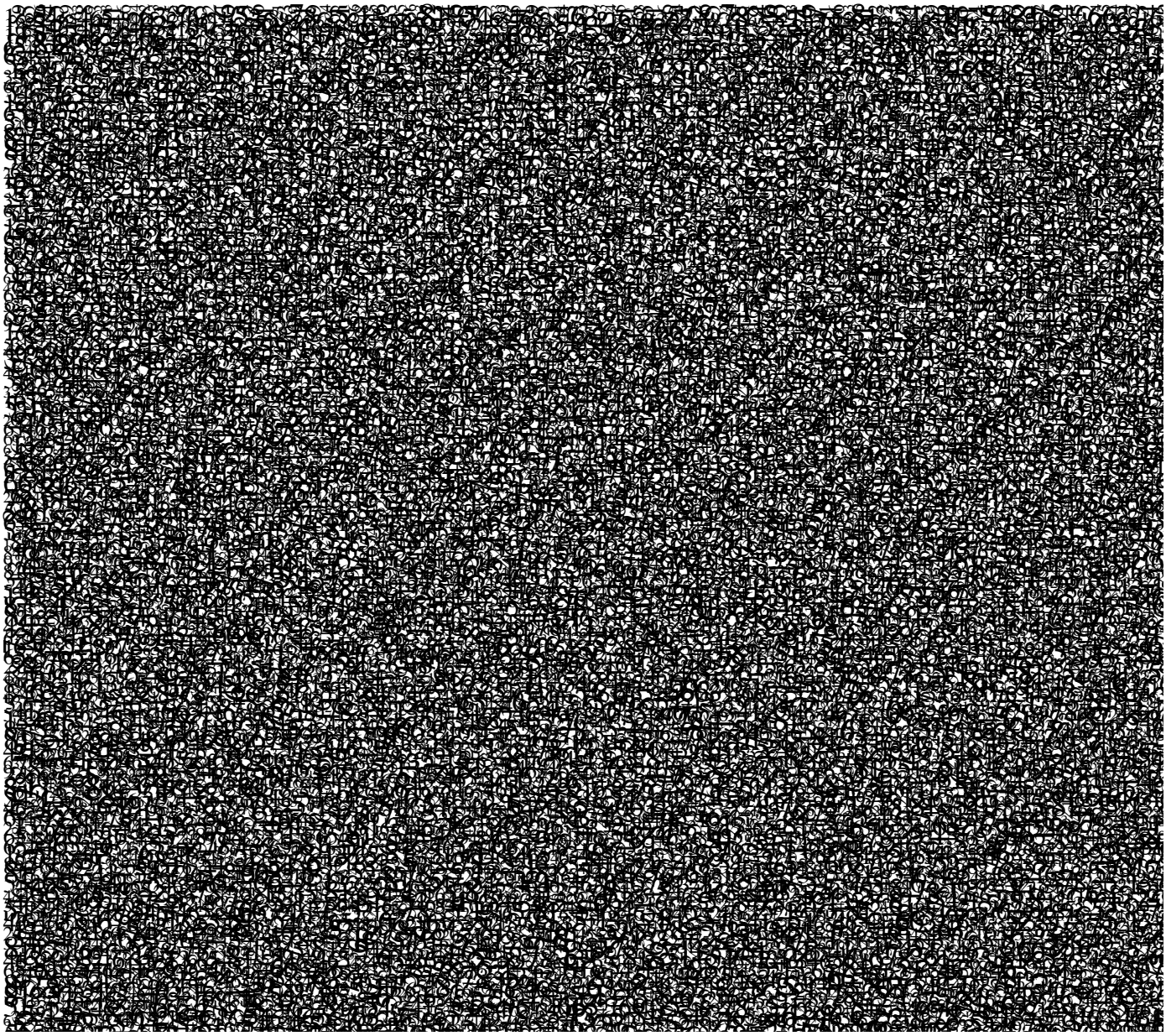
22

Auf Veranlassung von:

Arztnummer

Name des Therapeuten

Betriebsstättennummer



☐ Aufgrund somatischer/psychiatrischer Befunde bestehen derzeit Kontraindikationen für eine psychotherapeutische Behandlung (Begründung s. o.)

☐ Ärztliche Mitbehandlung ist erforderlich
Art der Maßnahme: _____

_____

Ausstellungsdatum

T T M M J J

Für diese Bescheinigung ist die Nr. 01612 EBM berechnungsfähig

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für die Krankenkasse

Anregung einer ambulanten Vorsorgeleistung in anerkannten Kurorten gem. § 23 Abs. 2 SGB V

- ☐ **bei Schwächung der Gesundheit / zur Krankheitsverhütung**
- ☐ **zur Vermeidung der Verschlimmerung behandlungsbedürftiger Krankheiten**
- ☐ **bei Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern**

Der/die Versicherte ist bei mir in Behandlung seit: ☐☐☐☐☐☐

Risikofaktoren/Gefährdung, Regulations-/Befindlichkeitsstörungen, Beschwerden

☐ erhöhter Blutdruck ☐ Bewegungsmangel/Fehlhaltung ☐ Übergewicht/ Fehlernährung ☐ Stress ☐ Rauchen

☐ Sonstige Risikofaktoren _____

☐ aktuelle Beschwerden (ggf. auch Regulations-/Befindlichkeitsstörungen): _____

Relevante Diagnosen in der Reihenfolge ihrer med. Bedeutung	seit wann?	Ursache	Verlauf
1.			
2.			
3.			

Ursache: 1 = Unfallfolgen; 2 = Berufskrankheit; 3 = Gesundheitsschäden nach dem BVG
Verlauf: 1 = chronisch rezidivierend; 2 = chronisch progredient; 3 = konstitutionell/umweltbedingte Neigung zu rezidivierenden somatischen Erkrankungen

Schädigungen/Funktionsstörungen/Befund:

Datum der letzten Untersuchung: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Aktuelle Befunde (z.B. Röntgen, EKG, Labor) / Untersuchungsberichte (z.B. Facharzt, Krankenhausentlassungsbericht)

☐ können bei Bedarf durch den MDK angefordert werden ☐ liegen nicht vor

Angestrebtes Vorsorgeziel (z.B. Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit, Abbau von Risikofaktoren, Verhaltensänderung):

Welche Behandlungen, Maßnahmen/Hilfen wurden in den letzten 12 Monaten durchgeführt?

☐ Krankengymnastik ☐ Physik. Therapie ☐ Stimm-, Sprech- oder Sprachtherapie ☐ Ergotherapie
☐ Psychotherapie ☐ Patientenschulung ☐ Rehasport/Funktionstraining ☐ Selbsthilfegruppe

☐ Sonstige (z.B. Hilfsmittelversorgung): _____

Nur ausfüllen, sofern in den letzten 3 Jahren eine medizinische Vorsorgeleistung durchgeführt wurde!

Die Vorsorgeleistung ist vor Ablauf der gesetzlichen Wartezeit von 3 Jahren medizinisch dringend erforderlich (z.B. Verschlimmerung durch akuten Schub, andere Krankheit), weil

Sind besondere Anforderungen an den Kurort zu stellen (z.B. Klima, Allergiefaktoren)?

☐ nein ☐ ja, welche _____

empfohlener Kurort: _____ **Dauer:** _____ Wochen

Durchführung der Vorsorgeleistung in kompakter Form (Kompaktkur) ☐ ja ☐ nein

Ggf. weitere Bemerkungen: _____

- Für die Angaben des Arztes ist die Nr. 01623 EBM berechnungsfähig -

Hinweis: Die vorstehend erfragten Angaben werden benötigt, um über den Antrag des Versicherten auf Durchführung einer Vorsorgeleistung entscheiden zu können. Nach §§ 100 SGB X und 73 Abs. 2 Ziff. 9 SGB V sind Sie verpflichtet, den erbetenen Bericht zu erteilen.

_____
Ort und Datum

~~gültig seit Juli 2009~~

verbindliches Muster

Unterschrift und Stempel des Vertragsarztes

Freigabe 07.07.2017

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V

26

Diagnose *(ICD-10-Code)*

Schweregrad *(lt. GAF-SKALA)*

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Art und Ausprägung der Fähigkeitsstörungen

Zusätzlich bei Diagnosen aus dem Bereich F00 bis F99 gemäß § 2 Abs. 5 der Richtlinie und GAF ≤ 40

Art und Ausprägung der Co-Morbiditäten / Sonstige Einschränkungen

Angaben des Versicherten

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Wohnform (z.B. alleinstehend in eigener Wohnung, Familie/Eltern, in Einrichtung)

Angaben des nächsten Angehörigen

Name

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Angaben zum Betreuer

Wurde ein gesetzlicher Betreuer bestellt? ☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, für welche Angelegenheiten?

Name

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Voraussichtliche Anzahl der Therapieeinheiten

Beantragte Anzahl der Therapieeinheiten

Voraussichtliche Dauer der Therapie

Bereits durchgeführte Leistungen

Prognose

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Begründung

Der soziotherapeutische Betreuungsplan ist beigefügt!

Für das Ausstellen der *Erst*verordnung ist die Nr. 30810 EBM berechnungsfähig.
Für das Ausstellen der *Folge*verordnung ist die Nr. 30811 EBM berechnungsfähig.

Diese Ausfertigung bitte zusammen mit dem soziotherapeutischen Betreuungsplan der Krankenkasse vorlegen!

Ausfertigung für die Krankenkasse

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 07.07.2017~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V

Diagnose
(ICD-10-Code)

Schweregrad
(lt. GAF-SKALA)

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Art und Ausprägung der Fähigkeitsstörungen

Zusätzlich bei Diagnosen aus dem Bereich F00 bis F99 gemäß § 2 Abs. 5 der Richtlinie und GAF ≤ 40

Art und Ausprägung der Co-Morbiditäten / Sonstige Einschränkungen

Angaben des Versicherten

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Wohnform (z.B. alleinstehend in eigener Wohnung, Familie/Eltern, in Einrichtung)

Angaben des nächsten Angehörigen

Name

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Angaben zum Betreuer

Wurde ein gesetzlicher Betreuer bestellt? ☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, für welche Angelegenheiten?

Name

Straße

PLZ | Ort

Telefonnummer

Voraussichtliche Anzahl der Therapieeinheiten

Beantragte Anzahl der Therapieeinheiten

Voraussichtliche Dauer der Therapie

Bereits durchgeführte Leistungen

Prognose

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Begründung

Der soziotherapeutische Betreuungsplan ist beigefügt!

Für das Ausstellen der *Erst*verordnung ist die Nr. 30810 EBM berechnungsfähig.
Für das Ausstellen der *Folge*verordnung ist die Nr. 30811 EBM berechnungsfähig.

Datum T T M M J J

Ausfertigung für den soziotherapeutischen Leistungserbringer

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 07.07.2017~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V

Diagnose
(ICD-10-Code)

Schweregrad
(lt. GAF-SKALA)

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Art und Ausprägung der Fähigkeitsstörungen

Zusätzlich bei Diagnosen aus dem Bereich F00 bis F99 gemäß § 2 Abs. 5 der Richtlinie und GAF ≤ 40

Art und Ausprägung der Co-Morbiditäten / Sonstige Einschränkungen

Angaben des Versicherten

Straße

PLZ Ort

Telefonnummer

Wohnform (z.B. alleinstehend in eigener Wohnung, Familie/Eltern, in Einrichtung)

Angaben des nächsten Angehörigen

Name

Straße

PLZ Ort

Telefonnummer

Angaben zum Betreuer

Wurde ein gesetzlicher Betreuer bestellt? ☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, für welche Angelegenheiten?

Name

Straße

PLZ Ort

Telefonnummer

Voraussichtliche Anzahl der Therapieeinheiten

Beantragte Anzahl der Therapieeinheiten

Voraussichtliche Dauer der Therapie

Bereits durchgeführte Leistungen

Prognose

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Begründung

Der soziotherapeutische Betreuungsplan ist beigefügt!

Für das Ausstellen der *Erst*verordnung ist die Nr. 30810 EBM berechnungsfähig.
Für das Ausstellen der *Folge*verordnung ist die Nr. 30811 EBM berechnungsfähig.

Datum T T M M J J

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V

27

(als Anlage zur Verordnung und zur Weiterleitung an die Krankenkasse)

IK des Leistungserbringers

Therapieziele (Nah- und Fernziele definieren)

Verordnete und empfohlene Maßnahmen, deren Inanspruchnahme zu koordinieren ist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen

Art der Maßnahmen	Frequenz pro Woche / Monat	Zeitraum

Ausstellungsdatum

Original bitte zusammen mit der Verordnung der Krankenkasse vorlegen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Datum | Unterschrift des Therapeuten

Datum | Unterschrift des Patienten

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V

(als Anlage zur Verordnung und zur Weiterleitung an die Krankenkasse)

IK des Leistungserbringers

Therapieziele (Nah- und Fernziele definieren)

Verordnete und empfohlene Maßnahmen, deren Inanspruchnahme zu koordinieren ist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen

Art der Maßnahmen	Frequenz pro Woche / Monat	Zeitraum

Ausstellungsdatum

Ausfertigung zum Verbleib beim soziotherapeutischen Leistungserbringer

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Datum | Unterschrift des Therapeuten

Datum | Unterschrift des Patienten

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V

(als Anlage zur Verordnung und zur Weiterleitung an die Krankenkasse)

IK des Leistungserbringers

Therapieziele (Nah- und Fernziele definieren)

Verordnete und empfohlene Maßnahmen, deren Inanspruchnahme zu koordinieren ist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen

Art der Maßnahmen	Frequenz pro Woche / Monat	Zeitraum

Ausstellungsdatum

Ausfertigung zum Verbleib beim verordnenden Arzt

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Datum | Unterschrift des Therapeuten

Datum | Unterschrift des Patienten

Freigabe 07.07.2017

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstellung für Soziotherapie gemäß § 37a SGB V im Umfang von maximal 5 Therapieeinheiten

28

Diagnose
(ICD-10-Code)

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Erklärung des Arztes
Mit dem Ziel, die Überweisung des Versicherten an einen verordnungsberechtigten Facharzt/Psychotherapeuten sicherzustellen, ziehe ich folgenden soziotherapeutischen Leistungserbringer hinzu

Name des soziotherapeutischen Leistungserbringers

Straße

PLZ | Ort

Für das Ausstellen dieses Vordrucks ist die Nr. 30800 EBM berechnungsfähig.

Datum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Soziotherapeutischer Leistungserbringer
Ich erkläre, dass ich einen Vertrag gem. § 132b SGB V geschlossen habe oder eine vergleichbare Abrechnungsgenehmigung der zuständigen Krankenkasse vorliegt.

IK des Leistungserbringers

Abrechnung des soziotherapeutischen Leistungserbringers
Folgende Leistungen wurden erbracht

Datum	Leistung
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	

Bemerkungen zur Abrechnung
Ich versichere, dass ich die aufgeführten Leistungen persönlich erbracht habe und bitte um Überweisung des vertraglich vereinbarten Betrages auf folgendes Konto

Kontoinhaber

IBAN

BIC | Geldinstitut

Diese Ausfertigung ist vom soziotherapeutischen Leistungserbringer an die Krankenkasse weiterzuleiten!

Ausfertigung für die Krankenkasse

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift des soziotherapeutischen Leistungserbringers

~~Freigabe 07.07.2017~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstellung für Soziotherapie gemäß § 37a SGB V im Umfang von maximal 5 Therapieeinheiten

Diagnose
(ICD-10-Code)

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Erklärung des Arztes
Mit dem Ziel, die Überweisung des Versicherten an einen verordnungsberechtigten Facharzt/Psychotherapeuten sicherzustellen, ziehe ich folgenden soziotherapeutischen Leistungserbringer hinzu

Name des soziotherapeutischen Leistungserbringers

Straße

PLZ | Ort

Für das Ausstellen dieses Vordrucks ist die Nr. 30800 EBM berechnungsfähig.

Datum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Soziotherapeutischer Leistungserbringer
Ich erkläre, dass ich einen Vertrag gem. § 132b SGB V geschlossen habe oder eine vergleichbare Abrechnungsgenehmigung der zuständigen Krankenkasse vorliegt.

IK des Leistungserbringers

Abrechnung des soziotherapeutischen Leistungserbringers
Folgende Leistungen wurden erbracht

Datum	Leistung
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	

Bemerkungen zur Abrechnung
Ich versichere, dass ich die aufgeführten Leistungen persönlich erbracht habe und bitte um Überweisung des vertraglich vereinbarten Betrages auf folgendes Konto

Kontoinhaber

IBAN

BIC | Geldinstitut

Verbindliches Muster

Datum T T M M J J

Ausfertigung für den soziotherapeutischen Leistungserbringer

Stempel und Unterschrift des soziotherapeutischen Leistungserbringers

~~Freigabe 07.07.2017~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstellung für Soziotherapie gemäß § 37a SGB V im Umfang von maximal 5 Therapieeinheiten

Diagnose
(ICD-10-Code)

Erkrankung besteht seit (falls bekannt) T T M M J J

Krankenhausbehandlung ☐ wird vermieden ☐ wird verkürzt ☐ ist nicht ausführbar

Erklärung des Arztes
Mit dem Ziel, die Überweisung des Versicherten an einen verordnungsberechtigten Facharzt/Psychotherapeuten sicherzustellen, ziehe ich folgenden soziotherapeutischen Leistungserbringer hinzu

Name des soziotherapeutischen Leistungserbringers

Straße

PLZ | Ort

Für das Ausstellen dieses Vordrucks ist die Nr. 30800 EBM berechnungsfähig.

Datum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Soziotherapeutischer Leistungserbringer
Ich erkläre, dass ich einen Vertrag gem. § 132b SGB V geschlossen habe oder eine vergleichbare Abrechnungsgenehmigung der zuständigen Krankenkasse vorliegt.

IK des Leistungserbringers

Abrechnung des soziotherapeutischen Leistungserbringers
Folgende Leistungen wurden erbracht

Datum	Leistung
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	

Bemerkungen zur Abrechnung
Ich versichere, dass ich die aufgeführten Leistungen persönlich erbracht habe und bitte um Überweisung des vertraglich vereinbarten Betrages auf folgendes Konto

Kontoinhaber

IBAN

BIC | Geldinstitut

Verbindliches Muster

Datum T T M M J J

Stempel und Unterschrift des soziotherapeutischen Leistungserbringers

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

Freigabe 09.05.2017

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Empfehlung 36

zur verhaltensbezogenen Primärprävention gem. § 20 Abs. 5 SGB V

- ☐ Bewegungsgewohnheiten
- ☐ Ernährung
- ☐ Stressmanagement
- ☐ Suchtmittelkonsum

Sonstiges

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften und anerkannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen.

Hinweise des behandelnden Arztes (z.B. Kontraindikationen, Konkretisierung zur Präventionsempfehlung)

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 10.11.2020~~

Krebsfrüherkennung Zervix-Karzinom

Auftragsnummer des Labors

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Alterskategorie

☐ 20-29 Jahre ☐ 30-34 Jahre ☐ ab 35 Jahre

Auftrag

(Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise für verschiedene Beauftragungsszenarien)

☐ Primär-screening ☐ Abklärungs-diagnostik

☐ Zytologie ☐ HPV-Test ☐ Ko-Testung (Zyt.+HPV)

Anamnese

Wurde bereits eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung durchgeführt?

☐ nein ☐ ja, zuletzt M M J J

Gruppe _____

HPV-Impfung

☐ vollständig
☐ unvollständig
☐ keine
☐ unklar

HPV-HR-Testergebnis

☐ liegt nicht vor
☐ liegt vor
- ☐ positiv
- ☐ negativ
- ☐ nicht verwertbar

Gynäkologische OP, Strahlen- oder Chemotherapie des Genitales

☐ nein ☐ ja Welche? _____

Wann? _____

Jetzt:

Letzte Periode T T M M J J

	nein	ja
Gravidität	☐	☐
Ausfluss / pathologische Blutung	☐	☐
IUP	☐	☐
Einnahme von Ovulationshemmer / sonstige Hormonanwendung	☐	☐

(ggf. bitte in Anmerkungen erläutern)

Klinischer Befund ☐ unauffällig ☐ auffällig

Erläuterungen ***ggf. gyn. Befunde (Vulva, Vagina, Portio); Diagnosen; sonstige Anmerkungen***

Ausfertigung für den untersuchenden Arzt

Zytologischer Befund / Kombinationsbefund

Eingangsdatum

T T M M J J

Endozervikale Zellen

☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Proliferationsgrad _____

☐ Döderleinflora ☐ Mischflora ☐ Kokkenflora

☐ Trichomonaden ☐ Candida ☐ Gardnerella

Gruppe _____

HPV-HR-Testergebnis

☐ positiv, wenn ja: Liegt HPV-Typ 16 oder HPV-Typ 18 vor?
- ☐ ja ☐ nein ☐ nicht differenzierbar

☐ negativ

☐ nicht verwertbar

Bemerkungen

Zusammenfassende Empfehlung

☐ zytologische Kontrolle
- ☐ nach Entzündungsbehandlung
- ☐ nach Östrogenbehandlung

☐ HPV-Test

☐ Ko-Test

☐ Abklärungskolposkopie

Zeitraum

☐ in _____ Monaten

☐ sofort

Vertragsarztstempel / Unterschrift des zytologisch tätigen Arztes

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 10.11.2020~~

Krebsfrüherkennung Zervix-Karzinom

Auftragsnummer des Labors

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Alterskategorie

☐ 20-29 Jahre ☐ 30-34 Jahre ☐ ab 35 Jahre

Auftrag

(Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise für verschiedene Beauftragungsszenarien)

☐ Primär-screening ☐ Abklärungs-diagnostik

☐ Zytologie ☐ HPV-Test ☐ Ko-Testung (Zyt.+HPV)

Anamnese

Wurde bereits eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung durchgeführt?

☐ nein ☐ ja, zuletzt M M J J

Gruppe _____

HPV-Impfung

☐ vollständig
☐ unvollständig
☐ keine
☐ unklar

HPV-HR-Testergebnis

☐ liegt nicht vor
☐ liegt vor
- ☐ positiv
- ☐ negativ
- ☐ nicht verwertbar

Gynäkologische OP, Strahlen- oder Chemotherapie des Genitales

☐ nein ☐ ja Welche? _____

Wann? _____

Jetzt:

Letzte Periode T T M M J J

	nein	ja
Gravidität	☐	☐
Ausfluss / pathologische Blutung	☐	☐
IUP	☐	☐
Einnahme von Ovulationshemmer / sonstige Hormonanwendung ***(ggf. bitte in Anmerkungen erläutern)***	☐	☐

Klinischer Befund ☐ unauffällig ☐ auffällig

Erläuterungen ***ggf. gyn. Befunde (Vulva, Vagina, Portio); Diagnosen; sonstige Anmerkungen***

Ausfertigung für den zytologisch tätigen Arzt

Zytologischer Befund / Kombinationsbefund

Eingangsdatum

T T M M J J

Endozervikale Zellen

☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Proliferationsgrad _____

☐ Döderleinflora ☐ Mischflora ☐ Kokkenflora

☐ Trichomonaden ☐ Candida ☐ Gardnerella

Gruppe _____

HPV-HR-Testergebnis

☐ positiv, wenn ja: Liegt HPV-Typ 16 oder HPV-Typ 18 vor?
- ☐ ja ☐ nein ☐ nicht differenzierbar

☐ negativ

☐ nicht verwertbar

Bemerkungen

Zusammenfassende Empfehlung

☐ zytologische Kontrolle
- ☐ nach Entzündungsbehandlung
- ☐ nach Östrogenbehandlung

☐ HPV-Test

☐ Ko-Test

☐ Abklärungskolposkopie

Zeitraum

☐ in _____ Monaten

☐ sofort

Vertragsarztstempel / Unterschrift des zytologisch tätigen Arztes

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Anfrage zur Zuständigkeit einer anderen Krankenkasse

Sehr geehrte(r) Frau / Herr _____

Sie haben am T T M M J J für Frau / Herrn

Name und Vorname des Versicherten

_____

Geburtsdatum

T T M M J J

Anschrift des Versicherten

_____

Versichertennummer

☐ eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

☐ folgende Verordnung(en) _____

☐ eine Verordnung von Krankenhausbehandlung

~~Freigabe 04.08.2005~~

ausgestellt.

Bitte geben Sie auf der Rückseite Auskunft zu folgendem Sachverhalt:

Bei uns kann keine Mitgliedschaft festgestellt werden bzw. die Mitgliedschaft endete am T T M M J J

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage
Freiumschlag

Für die Beantwortung dieser Anfrage ist die Nr. 01620 EBM berechnungsfähig

Verbindliches Muster

Vom Vertragsarzt auszufüllen!

Wurde der Name und das Geburtsdatum von uns richtig wiedergegeben? ☐ ja ☐ nein

Wenn nein, bitte berichtigen:
Name und Vorname des Versicherten

Geburtsdatum
T T M M J J

Hat ein Behandlungsausweis zum Zeitpunkt der Behandlung vorgelegen? ☐ ja ☐ nein

Name der Krankenkasse

Bei Kassenwechsel:
Name der neuen Krankenkasse

Bitte nur bei Angabe einer neuen Krankenkasse ausfüllen!

Behandlungstag	EBM-Nr.	Behandlungstag	EBM-Nr.
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	

Ausstellungsdatum
T T M M J J

~~Freigabe 04.08.2005~~

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Anfrage zur Zuständigkeit eines sonstigen Kostenträgers

Sehr geehrte(r) Frau / Herr _____

Sie haben am | T | T | M | M | J | J | für Frau / Herrn

Name und Vorname des Versicherten

_____

Geburtsdatum

| T | T | M | M | J | J |

Anschrift des Versicherten

_____

Versichertennummer

☐ eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

☐ folgende Verordnung(en) _____

☐ eine Verordnung von Krankenhausbehandlung

ausgestellt.

Bitte geben Sie auf der Rückseite Auskunft zu folgendem Sachverhalt:

☐ 1. Nach unseren Unterlagen liegt

- ☐ ein Arbeitsunfall (auch Wegeunfall oder Berufskrankheit)
- ☐ ein sonstiger Unfall (Sportunfall, häuslicher- oder Verkehrsunfall) bzw. Gewalteinwirkung

vor.

☐ 2. Es besteht möglicherweise ein ursächlicher Zusammenhang mit dem/den anerkannten Versorgungsleiden

_____ **~~Freigabe 08.08.2005~~**

_____

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Verbindliches Muster

Anlage
Freiumschlag

Für die Beantwortung dieser Anfrage ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Vom Vertragsarzt auszufüllen!

zu 1. Angaben bei Arbeitsunfall / sonstigem Unfall / Drittschädigung

Wurde der Patient wegen des Unfalls oder der Schädigung überwiesen?

☐ nein

☐ ja, und zwar ☐ an einen anderen Arzt ☐ von einem anderen Arzt

Name des Arztes Anschrift

Wurden von Ihnen Leistungen (z.B. Arzneimittel, Heil-/Hilfsmittel, Krankentransport aufgrund des Unfalls) veranlasst / verordnet? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, welche? (bitte genaue Bezeichnung)

Dauert die Behandlung noch an? ☐ ja ☐ nein

Ist mit Spätfolgen zu rechnen? ☐ ja ☐ nein ☐ noch nicht absehbar

Bitte in jedem Fall ausfüllen!

Behandlungstag	EBM-Nr.	Behandlungstag	EBM-Nr.
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	
T T M M J J		T T M M J J	

zu 2. Angaben zum ursächlichen Zusammenhang mit dem Versorgungsleiden

Steht die für die Bescheinigung / Verordnung (s. Vorderseite) maßgebliche Diagnose im ursächlichen Zusammenhang mit den anerkannten Versorgungsleiden? ☐ ja ☐ nein ☐ zweifelhaft

Nur bei Arbeitsunfähigkeit / Krankenhauseinweisung!

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung / Krankenhauseinweisung war

☐ ausschließlich / überwiegend wegen der anerkannten Schädigungsfolgen vom T T M M J J bis T T M M J J

☐ überwiegend wegen anderer Leiden vom T T M M J J bis T T M M J J

Bitte in jedem Fall ausfüllen!

Behandlungstag	EBM-Nr.
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	
T T M M J J	

Ausstellungsdatum T T M M J J

~~**Freigabe 08.08.2005**~~

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 2024-11-06~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit

52

1. Wegen welcher Diagnose(n) (ICD-10) besteht die Arbeitsunfähigkeit?

ICD-10 - Code | ICD-10 - Code | ICD-10 - Code | ICD-10 - Code | ICD-10 - Code | ICD-10 - Code

ggf. Angabe sich daraus ergebender Funktionseinschränkungen

2. Welche Tätigkeiten übte die/der Versicherte bis zum Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus?
(Bei Empfängern von Arbeitslosengeld bitte 2.2 beantworten.)

2.1 erwerbstätig als

regelmäßige Arbeitszeit ☐☐ Stunden pro Woche

2.2 ☐ Die/der Versicherte ist Empfänger von Arbeitslosengeld und hat sich vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit für folgende Stundenanzahl der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestellt ☐☐ Stunden pro Woche

Kann der Empfänger von Arbeitslosengeld in diesem Umfang leichte Tätigkeiten ausüben? ☐ nein ☐ ja

3. Welche diagnostischen/therapeutischen/rehabilitativen Maßnahmen sind in Bezug auf die Arbeitsunfähigkeit auslösende(n) Diagnose(n) vorgesehen?

konservativ
(ggf. wann und welche)

operativ
(ggf. wann und welche)

Heilmittel
(ggf. seit wann und welche)

Stufenweise Wiedereingliederung
(gilt nicht für Arbeitslose) ☐ geplant ☐ eingeleitet

Medizinische Rehabilitation ☐ geplant ☐ beantragt

Patientenschulung ☐ geplant ☐ eingeleitet

Sonstige (therapeutische) Maßnahmen ***(ggf. wann und welche)***
z. B. Rückenschule, Ernährungsberatung, Suchttherapie, Psychotherapeutische Behandlung, Leistungen zur Teilhabe, Rehabilitationssport/Funktionstraining oder betriebliches Eingliederungsmanagement

☐ keine ***(Begründung erforderlich)***

4. Erfolgte eine Überweisung zur fachärztlichen Mitbehandlung?

☐ nein ☐ ja, Fachrichtung

5. Besteht oder droht eine Erwerbsminderung?

☐ nein ☐ ja

Für das Ausstellen dieses Berichts ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Ausstellungsdatum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

Anfrage zum Zusammenhang von Arbeitsunfähigkeitszeiten

Sehr geehrte(r) Frau / Herr _____ **~~Freigabe 04.08.2005~~**

Ihr Patient / unser Mitglied

Name und Vorname des Versicherten

Geburtsdatum T T M M J J

_____

Anschrift des Versicherten

_____

Versichertennummer

ist seit T T M M J J

☐ arbeitsunfähig erkrankt

☐ in stationärer Behandlung

Um die Dauer des Leistungsanspruchs prüfen zu können, teilen Sie uns bitte mit, ob die Arbeitsunfähigkeit mit den vorherigen Arbeitsunfähigkeitszeiten (Daten siehe Rückseite) in ursächlichem Zusammenhang steht.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage
Freiumschlag

Verbindliches Muster

Für die Beantwortung dieser Anfrage ist die Nr. 01621 EBM berechnungsfähig

Von der Krankenkasse auszufüllen!

I. Arbeitsunfähig vom T T M M J J bis T T M M J J

wegen

_____

_____

II. Vorher bestand Arbeitsunfähigkeit wegen	vom	bis	behandelnder Arzt
1 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____
2 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____
3 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____
4 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____
5 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____
6 _____	T T M M J J	T T M M J J	_____

Vom Vertragsarzt auszufüllen!

Handelt es sich bei der unter I. angegebenen Krankheit und einer der unter II. genannten Krankheiten um dieselbe Krankheit* im Sinne der unten abgedruckten versicherungsrechtlichen Erläuterungen?

☐ nein ☐ ja, und zwar bei der/den unter Ziffer(n) _____ genannten Krankheit(en).

III. Sind während der unter I. genannten Arbeitsunfähigkeit weitere Krankheiten hinzugetreten?

☐ nein ☐ ja, und zwar _____

_____ am T T M M J J

Wird die Arbeitsunfähigkeit nur noch von der/den hinzugetretenen Krankheit(en) bedingt?

☐ nein ☐ ja, und zwar _____

_____ ab T T M M J J

Handelt es sich bei der hinzugetretenen Krankheit und einer unter II. genannten früheren Erkrankung um dieselbe Krankheit* im Sinne der unten abgedruckten versicherungsrechtlichen Erläuterungen?

☐ nein ☐ ja, und zwar bei der/den unter Ziffer(n) _____ genannten Krankheit(en).

Ergänzende Bemerkungen

_____

_____

_____

_____

Ausstellungsdatum T T M M J J

Freigabe 04.08.2005

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

***) Versicherungsrechtliche Erläuterungen**

Der Begriff "dieselbe Krankheit" setzt nicht vorraus, dass fortlaufende Behandlungsbedürftigkeit besteht. Bei wiederholter Arbeitsunfähigkeit kommt es darauf an, ob die neue Arbeitsunfähigkeit und die frühere(n) auf derselben Krankheitsursache beruhen oder zumindest in einem inneren Zusammenhang mit ihr stehen. Der innere Zusammenhang kann schon dadurch begründet sein, dass die Entstehung der Krankheit jedesmal durch eine gemeinsame Bedingung begünstigt oder herbeigeführt wird.

Freigabe 08.07.2016

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Bescheinigung einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung gem. § 62 SGB V

55

Seit T T M M J J

(mindestens 4 Quartale zurückliegend)

ist der Versicherte wegen derselben Erkrankung in Dauerbehandlung.

behandlungsbedürftige Dauerdiagnose(n) ***(ICD-10)***

ICD-10 - Code	ICD-10 - Code	ICD-10 - Code

Kontinuierliche medizinische Versorgung der oben genannten Erkrankung ist weiterhin erforderlich

- ☐ ja, Ende der Dauerbehandlung derzeit nicht absehbar
- ☐ ja, voraussichtlich bis M M J J
- ☐ nein

Die Vergütung für das Ausstellen dieser Bescheinigung erfolgt über die hausärztliche Versichertenpauschale bzw. ist die Nr. 01610 EBM berechnungsfähig.

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Gegebenenfalls vom Versicherten auszufüllen

Wird der Antrag auf Zuzahlungsbefreiung für den umseitig genannten Versicherten gestellt, sind KEINE weiteren Angaben erforderlich. Dies gilt auch, wenn der Antrag durch den Betreuer für den Versicherten gestellt wird.

In allen anderen Fällen (z. B. gemeinsamer Antrag über den Ehegatten) werden die nachfolgenden Angaben benötigt. Ohne diese Angaben kann die Bescheinigung nicht korrekt zugeordnet werden.

Die Bescheinigung ist bei der Krankenkasse einzureichen, bei der der Antrag auf Zuzahlungsbefreiung gestellt wird/wurde.

Angaben zum antragstellenden Versicherten

Name, Vorname

Geburtsdatum

T T M M J J

Krankenkasse

Verbindliches Muster

Freigabe 08.07.2016

Krankenversichertennummer

Freigabe 09.09.2022

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Antrag auf Kostenübernahme 56

☐ **für Rehabilitationssport**

☐ **für Funktionstraining**

Rehabilitationssport/Funktionstraining werden von den Krankenkassen insbesondere mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung gestellt.

Ärztliche Verordnung für Rehabilitationssport/Funktionstraining

verordnungsrelevante Diagnose(n), gegebenenfalls relevante Nebendiagnose

Diagnoseschlüssel ICD-10-GM

Schädigung der Körperfunktionen und Körperstrukturen für die verordnungsrelevante(n) Beeinträchtigung(en) der Aktivität(en) und Teilhabe

Ziel des Rehabilitationssports/Funktionstrainings

Verbindliches Muster

☐ erhöhter Teilhabebedarf für schwerstbehinderte Menschen (z. B. Blindheit, Doppelamputation oder Hirnverletzung)

Empfohlene Rehabilitationssportart

☐ Gymnastik (auch im Wasser) ☐ Schwimmen ☐ Ausdauer- und Kraftausdauerübungen

☐ Bewegungsspiele ☐ Sonstige

☐ Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Mädchen erforderlich

Rehabilitationssport ist notwendig für

☐ 50 Übungseinheiten in 18 Monaten (Richtwerte)

☐ 120 Übungseinheiten in 36 Monaten (Richtwerte) insbesondere bei folgenden Krankheiten mit daraus resultierenden schweren Beeinträchtigungen insbesondere der Mobilität oder Selbstversorgung

☐	Asthma bronchiale	☐	Morbus Parkinson
☐	Blindheit, in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung erworben	☐	Mukoviszidose
☐	Chronisch-obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	☐	Multipler Sklerose
☐	Dementielles Syndrom, leicht bis mittelgradig	☐	Muskeldystrophie
☐	Diabetes mellitus mit Folgeerkrankungen	☐	Niereninsuffizienz, terminal
☐	Doppelamputation	☐	Organische Hirnschädigung
☐	Epilepsie, therapieresistent	☐	Polyneuropathie
☐	Infantile Zerebralparese	☐	Querschnittlähmung, schwere Lähmung
☐	Intelligenzminderung, mittelgradig		
☐	Morbus Bechterew	☐	andere vergl. Krankheit(en) (vgl. Diagnose/Nebendiagnose)

☐ 28 Übungseinheiten (Richtwert) zur Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Mädchen erforderlich

Empfohlene Funktionstrainingsarten

☐ Trockengymnastik

☐ Wassergymnastik

Funktionstraining ist notwendig für

☐ 12 Monate (Richtwert)

☐ 24 Monate (Richtwert) nur bei folgenden gesicherten chronischen Krankheiten/Behinderungen bei schwerer Beeinträchtigung der Beweglichkeit/Mobilität

☐	Fibromyalgie-Syndrom
☐	Kollagenosen
☐	Morbus Bechterew
☐	Osteoporose
☐	Polyarthrosen, schwer
☐	Psoriasis-Arthritis
☐	Rheumatoide Arthritis

Längere Leistungsdauer, wenn bei kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in Eigenverantwortung nicht oder noch nicht möglich ist.

☐ 120 Übungseinheiten in 36 Monaten (Richtwerte)

☐ 24 Monate (Richtwert)

☐ **Folgeverordnung mit Begründung,**
warum erlernte Übungen nicht oder noch nicht selbstständig durchgeführt werden können

Rehabilitationssport ist notwendig für ☐ Herzgruppe ☐ Herzinsuffizienzgruppe (bei hohem kardiovaskulären Ereignisrisiko)

☐ **Erstverordnung** 90 Übungseinheiten in 24 Monaten (Richtwerte)

☐ **Folgeverordnung** 45 Übungseinheiten in 12 Monaten (Richtwerte)

- ☐ nur bei Belastungsgrenze < 1,4 Watt/kg Körpergewicht
- ☐ wenn bei kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in Eigenverantwortung nicht oder noch nicht möglich ist

☐ **Kinderherzgruppen** 120 Übungseinheiten in 24 Monaten (Richtwerte)

Empfohlene Anzahl wöchentlicher Übungseinheiten ***(max. 3 Einheiten je Woche / Begründung bei insgesamt 3 Einheiten)***

Rehabilitationssport
☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x

Funktionstraining als Trockengymnastik ☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x

Funktionstraining als Wassergymnastik ☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x

Begründung bei insgesamt 3x

Abweichung von oben genannten Richtwerten

☐☐☐ Übungseinheiten bei Rehabilitationssport / Monate bei Funktionstraining

Für die ärztliche Verordnung ist die Nr. 01621 EBM berechnungsfähig

Datum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Antrag auf Kostenübernahme

Rehabilitationssport/Funktionstraining soll bei folgendem Leistungserbringer durchgeführt werden

Verein, Träger usw., Postleitzahl, Ort

☐ Ich nehme am Rehabilitationssport/ Funktionstraining bereits teil seit M M J J

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten

Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse

Die Kosten werden entsprechend der bestehenden Vereinbarung übernommen zur Durchführung und Finanzierung des

☐ **Rehabilitationssports**

- ☐ 50 Übungseinheiten / 18 Monate
- ☐ 120 Übungseinheiten / 36 Monate
- ☐ Herzgruppe ☐ Herzinsuffizienzgruppe
- ☐ 90 Übungseinheiten / 24 Monate
- ☐ 45 Übungseinheiten / 12 Monate
- ☐ 120 Übungseinheiten / 24 Monate (Kinderherzgruppen)
- ☐ 28 Übungseinheiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins
- ☐☐☐ Übungseinheiten

☐ **Funktionstrainings**

- ☐ 12 Monate
- ☐ 24 Monate
- ☐☐ Monate

Anzahl wöchentlicher Übungsveranstaltungen

☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x

für den Zeitraum vom T T M M J J längstens bis T T M M J J

Diese Erklärung erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein Leistungsanspruch gegenüber unserer Krankenkasse weiter besteht

Datum T T M M J J

~~Freigabe 09.09.2022~~

Verbindliches Muster

Stempel der Krankenkasse / Unterschrift

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Freigabe 23.03.2022

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Beratung zu medizinischer Rehabilitation / Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers

61 Teil A

Hinweis an den Arzt zur Zuständigkeit der Krankenkasse

Ist eine medizinische Rehabilitation erforderlich, weil krankheits-/behinderungsbedingt nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bestehen oder drohen, kann die Zuständigkeit der Krankenkasse bestehen (z. B. bei Altersrentnern, spezifischen Leistungen der medizinischen Rehabilitation für Mütter/Väter).
Ist eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit gegeben, besteht grundsätzlich die Zuständigkeit der Rentenversicherung.
Handelt es sich um die Folge eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit, ist grundsätzlich die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung gegeben.

Bei Zuständigkeit der Krankenkasse bitte NUR Muster 61 Teil B-E ausfüllen.

I. Rehabilitationsbegründende und weitere Diagnosen

		Diagnoseschlüssel ICD-10-GM	Ursache *
A. Rehabilitationsbegründende Funktionsdiagnosen			
1.			
2.			
3.			
B. Weitere rehabilitationsrelevante Diagnosen			
4.			
5.			
6.			

**** Mögliche Ursache der Erkrankung***
(nur anzugeben, wenn eine der folgenden Ursachen zutrifft)

- ***1 = Arbeitsunfall einschl. Wegeunfall***
- ***2 = Berufskrankheit***
- ***3 = Schädigungsfolge durch Einwirken Dritter (z. B. Unfallfolgen)***
- ***4 = Folgen von Kriegs-, Zivil- oder Wehrdienst***
- ***5 = Meldepflichtige Erkrankung (z. B. IfSG)***

II. Hinweis/Anfrage an die Krankenkasse

☐ **Beratung der/des Versicherten**
Bitte NUR Teil A an die Krankenkasse übermitteln. Teil B-E ist NICHT auszufüllen.

Eine **Beratung der/des Versicherten** über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Krankenkasse und/oder Rentenversicherung (z. B. bei gleichrangiger Zuständigkeit für Leistungen der Kinder-Rehabilitation oder onkologischen Rehabilitation für Altersrentner) bzw. weitere Leistungen der Krankenkasse (z. B. zur medizinischen Vorsorge in anerkannten Kurorten) **ist angezeigt**.

☐ **Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers**
Bitte NUR Teil A an die Krankenkasse übermitteln. Teil B-E ist NICHT auszufüllen.

Eine **medizinische Rehabilitation ist erforderlich**, weil krankheits-/behinderungsbedingt eine Minderung der Erwerbsfähigkeit besteht oder droht. **Es wird die Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers erbeten**, weil z. B. die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Rentenversicherung nicht eindeutig beurteilt werden können.

ggf. weitere Anmerkungen

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

III. Im Original zurück an die Vertragsärztin / den Vertragsarzt

Folgender Rehabilitationsträger ist zuständig

☐ Krankenkasse ***(bitte Muster 61 Teil B-E ausfüllen)***

☐ Rentenversicherung ***(Vordruck liegt bei)***

☐ Sonstiges

Stempel / Unterschrift der Krankenkasse

Krankenkasse bzw. Kostenträger

~~Freigabe 23.03.2022~~

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Beratung zu medizinischer Rehabilitation / Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers

61 Teil A

Hinweis an den Arzt zur Zuständigkeit der Krankenkasse

Ist eine medizinische Rehabilitation erforderlich, weil krankheits-/behinderungsbedingt nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bestehen oder drohen, kann die Zuständigkeit der Krankenkasse bestehen (z. B. bei Altersrentnern, spezifischen Leistungen der medizinischen Rehabilitation für Mütter/Väter).
Ist eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit gegeben, besteht grundsätzlich die Zuständigkeit der Rentenversicherung.
Handelt es sich um die Folge eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit, ist grundsätzlich die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung gegeben.

Bei Zuständigkeit der Krankenkasse bitte NUR Muster 61 Teil B-E ausfüllen.

I. Rehabilitationsbegründende und weitere Diagnosen

		Diagnoseschlüssel ICD-10-GM	Ursache *
A. Rehabilitationsbegründende Funktionsdiagnosen			
1.			
2.			
3.			
B. Weitere rehabilitationsrelevante Diagnosen			
4.			
5.			
6.			

**** Mögliche Ursache der Erkrankung***
(nur anzugeben, wenn eine der folgenden Ursachen zutrifft)

- ***1 = Arbeitsunfall einschl. Wegeunfall***
- ***2 = Berufskrankheit***
- ***3 = Schädigungsfolge durch Einwirken Dritter (z. B. Unfallfolgen)***
- ***4 = Folgen von Kriegs-, Zivil- oder Wehrdienst***
- ***5 = Meldepflichtige Erkrankung (z. B. IfSG)***

II. Hinweis/Anfrage an die Krankenkasse

☐ **Beratung der/des Versicherten**
Bitte NUR Teil A an die Krankenkasse übermitteln. Teil B-E ist NICHT auszufüllen.

Eine **Beratung der/des Versicherten** über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Krankenkasse und/oder Rentenversicherung (z. B. bei gleichrangiger Zuständigkeit für Leistungen der Kinder-Rehabilitation oder onkologischen Rehabilitation für Altersrentner) bzw. weitere Leistungen der Krankenkasse (z. B. zur medizinischen Vorsorge in anerkannten Kurorten) **ist angezeigt**.

☐ **Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers**
Bitte NUR Teil A an die Krankenkasse übermitteln. Teil B-E ist NICHT auszufüllen.

Eine **medizinische Rehabilitation ist erforderlich**, weil krankheits-/behinderungsbedingt eine Minderung der Erwerbsfähigkeit besteht oder droht. **Es wird die Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers erbeten**, weil z. B. die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Rentenversicherung nicht eindeutig beurteilt werden können.

ggf. weitere Anmerkungen

Datum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

III. Im Original zurück an die Vertragsärztin / den Vertragsarzt

Folgender Rehabilitationsträger ist zuständig

☐ Krankenkasse ***(bitte Muster 61 Teil B-E ausfüllen)***

☐ Rentenversicherung ***(Vordruck liegt bei)***

☐ Sonstiges

Stempel / Unterschrift der Krankenkasse

Muster 61 Teil Ab (7.2022)

Bitte vor der Beschriftung der Formulare diese Fußleiste abreißen und die 5 Einzelsätze voneinander trennen

Freigabe 23.03.2022

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung von medizinischer Rehabilitation

61 Teil B

Die kurative Versorgung ist nicht ausreichend

☐ Es handelt sich weder um eine Minderung / erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit noch um die Folgen eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit

Bei gleichrangiger Zuständigkeit
(z. B. Kinder-Rehabilitation, onkologische Rehabilitation für Altersrentner)

☐ Versicherte/r wünscht eine medizinische Rehabilitation zu Lasten der GKV

I. Rehabilitationsbegründende und weitere Diagnosen

A. Rehabilitationsbegründende Funktionsdiagnosen

		Diagnoseschlüssel ICD-10-GM	Ursache *
1.			
2.			
3.			

B. Weitere rehabilitationsrelevante/geriatrietypische Diagnosen

4.			
5.			
6.			

**** Mögliche Ursache der Erkrankung***
(nur anzugeben, wenn eine der folgenden Ursachen zutrifft)

- ***1 = Arbeitsunfall einschl. Wegeunfall***
- ***2 = Berufskrankheit***
- ***3 = Schädigungsfolge durch Einwirken Dritter (z. B. Unfallfolgen)***
- ***4 = Folgen von Kriegs-, Zivil- oder Wehrdienst***
- ***5 = Meldepflichtige Erkrankung (z. B. IfSG)***

II. Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit und zum Verlauf der Krankenbehandlung

A. Kurze Angaben zur Anamnese *(insbesondere Beginn und Verlauf)* und zu Krankenhaus- und Facharztbehandlung

B. Rehabilitationsrelevante Schädigungen und Befunde *(relevante Untersuchungsergebnisse / aktuelle Assessmentergebnisse)*

C. Bei geriatrischer Rehabilitation
mind. zwei Funktionstests folgender unterschiedlicher Schädigungsbereiche

Mobilität	Kognition	Schmerz	Herz-/Lungenfunktion
TUG ___ sek + Chair Rise ___ sek	MMST ___ / 30	Schmerz-skala ___ / 10	Ergometrie ___ Watt
Hand-kraft ___ kg **oder** ___ kpa	GDS 15 ___ / 15		FEV1 ___ % + VK ___ %
DEMMI ___ / 100 Tinetti ___ / 28	Uhren-test ___ / 7		NYHA-Stadium ___

D. Bisherige ärztliche/psychotherapeutische Interventionen sowie andere Maßnahmen *(z. B. Patientenschulungen, Rehabilitationssport/Funktionstraining, Beratungs- und Selbsthilfeangebote)*; einschließlich Heilmittelverordnung *(in den letzten 6 Monaten)*

Verbindliches Muster

☐ Heilmittel zur Erreichung des Behandlungszieles nicht ausreichend

E. Rehabilitationsrelevante Hilfsmittel

☐ nein ☐ ja, welche?

Ausfertigung für die Krankenkasse

Freigabe ~~23.03.2022~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung von medizinischer Rehabilitation

61 Teil B

Die kurative Versorgung ist nicht ausreichend

☐ Es handelt sich weder um eine Minderung / erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit noch um die Folgen eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit

Bei gleichrangiger Zuständigkeit
(z. B. Kinder-Rehabilitation, onkologische Rehabilitation für Altersrentner)

☐ Versicherte/r wünscht eine medizinische Rehabilitation zu Lasten der GKV

I. Rehabilitationsbegründende und weitere Diagnosen

A. Rehabilitationsbegründende Funktionsdiagnosen

		Diagnoseschlüssel ICD-10-GM	Ursache *
1.			
2.			
3.			

B. Weitere rehabilitationsrelevante/geriatrietypische Diagnosen

4.			
5.			
6.			

**** Mögliche Ursache der Erkrankung***
(nur anzugeben, wenn eine der folgenden Ursachen zutrifft)

- ***1 = Arbeitsunfall einschl. Wegeunfall***
- ***2 = Berufskrankheit***
- ***3 = Schädigungsfolge durch Einwirken Dritter (z. B. Unfallfolgen)***
- ***4 = Folgen von Kriegs-, Zivil- oder Wehrdienst***
- ***5 = Meldepflichtige Erkrankung (z. B. IfSG)***

II. Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit und zum Verlauf der Krankenbehandlung

A. Kurze Angaben zur Anamnese *(insbesondere Beginn und Verlauf)* und zu Krankenhaus- und Facharztbehandlung

B. Rehabilitationsrelevante Schädigungen und Befunde *(relevante Untersuchungsergebnisse / aktuelle Assessmentergebnisse)*

C. Bei geriatrischer Rehabilitation
mind. zwei Funktionstests folgender unterschiedlicher Schädigungsbereiche

Mobilität	Kognition	Schmerz	Herz-/Lungenfunktion
TUG ___ sek + Chair Rise ___ sek	MMST ___ / 30	Schmerzskala ___ / 10	Ergometrie ___ Watt
Handkraft ___ kg **oder** ___ kpa	GDS 15 ___ / 15		FEV1 ___ % + VK ___ %
DEMMI ___ / 100 Tinetti ___ / 28	Uhrentest ___ / 7		NYHA-Stadium ___

D. Bisherige ärztliche/psychotherapeutische Interventionen sowie andere Maßnahmen *(z. B. Patientenschulungen, Rehabilitationssport/Funktionstraining, Beratungs- und Selbsthilfeangebote)*; einschließlich Heilmittelverordnung *(in den letzten 6 Monaten)*

Verbindliches Muster

☐ Heilmittel zur Erreichung des Behandlungszieles nicht ausreichend

E. Rehabilitationsrelevante Hilfsmittel

☐ nein ☐ ja, welche?

Ausfertigung für den Vertragsarzt

Name, Vorname des Versicherten	Freigabe 23.03.2022 Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

F. Nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe

	keine Beeinträchtigungen	Einschränkungen	personelle Hilfe nötig	nicht durchführbar
Lernen und Wissensanwendung *(z. B. Probleme lösen, Entscheidungen treffen)*	☐	☐	☐	☐
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen *(z. B. tägliche Routine durchführen, mit Belastungen, Krisen sowie Stress umgehen)*	☐	☐	☐	☐
Kommunikation *(z. B. Konversation betreiben, Mitteilungen schreiben, Kommunikationsgeräte benutzen können)*	☐	☐	☐	☐
Mobilität	☐			
Transfer Bett / Stuhl bzw. Rollstuhl	☐	☐	☐	☐
Stehen / Gehen	☐	☐	☐	☐
Treppensteigen	☐	☐	☐	☐
Sonstige		☐	☐	☐
Selbstversorgung	☐			
Essen / Trinken	☐	☐	☐	☐
An- / Auskleiden	☐	☐	☐	☐
Waschen	☐	☐	☐	☐
Baden / Duschen	☐	☐	☐	☐
Toilettenbenutzung	☐	☐	☐	☐
Sonstige		☐	☐	☐
Häusliches Leben *(z. B. Einkaufen, Mahlzeiten vorbereiten, Hausarbeit verrichten, anderen Familienmitgliedern helfen)*	☐	☐	☐	☐
Interpersonelle Aktivitäten *(z. B. Familienbeziehungen aufbauen und aufrechterhalten, soziale Beziehungen aufnehmen)*	☐	☐	☐	☐
Bedeutende Lebensbereiche *(z. B. Arbeit und Beschäftigung, Erziehung und Bildung, wirtschaftliche Eigenständigkeit, sich beschäftigen können)*	☐	☐	☐	☐
Gemeinschaftsleben und soziales Leben *(z. B. am Gemeinschaftsleben beteiligen, Erholung und Freizeit)*	☐	☐	☐	☐

G. Lebensumstände/Kontextfaktoren

1. Rehabilitationsrelevante umwelt- und personbezogene Faktoren

(z. B. allein / mit Familie lebend, in Alten-/Pflegeeinrichtung lebend, Konflikte, Pflege oder Tod eines Familienangehörigen, Unterstützung(-sbedarf), sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, Mehrfachbelastung, mangelndes Selbstmanagement, soziale Isolation, Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen)

Verbindliches Muster

2. Risikofaktoren oder Gefährdung durch

☐ Bewegungsmangel Fehlhaltung BMI ____ ☐ Fehl-/Mangelernährung ☐ Medikamente ☐ Nikotin

☐ Sonstiges *z.B. Suchtmittel* ____

III. Angaben zur Rehabilitationsfähigkeit

Der/die Patient/in verfügt über ausreichende physische und psychische Belastbarkeit ☐ ja ☐ nein

Ausfertigung für die Krankenkasse

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

61 Teil C

F. Nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe

	keine Beeinträchtigungen	Einschränkungen	personelle Hilfe nötig	nicht durchführbar
Lernen und Wissensanwendung *(z. B. Probleme lösen, Entscheidungen treffen)*	☐	☐	☐	☐
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen *(z. B. tägliche Routine durchführen, mit Belastungen, Krisen sowie Stress umgehen)*	☐	☐	☐	☐
Kommunikation *(z. B. Konversation betreiben, Mitteilungen schreiben, Kommunikationsgeräte benutzen können)*	☐	☐	☐	☐
Mobilität	☐			
Transfer Bett / Stuhl bzw. Rollstuhl	☐	☐	☐	☐
Stehen / Gehen	☐	☐	☐	☐
Treppensteigen	☐	☐	☐	☐
Sonstige _____		☐	☐	☐
Selbstversorgung	☐			
Essen / Trinken	☐	☐	☐	☐
An- / Auskleiden	☐	☐	☐	☐
Waschen	☐	☐	☐	☐
Baden / Duschen	☐	☐	☐	☐
Toilettenbenutzung	☐	☐	☐	☐
Sonstige _____		☐	☐	☐
Häusliches Leben *(z. B. Einkaufen, Mahlzeiten vorbereiten, Hausarbeit verrichten, anderen Familienmitgliedern helfen)*	☐	☐	☐	☐
Interpersonelle Aktivitäten *(z. B. Familienbeziehungen aufbauen und aufrechterhalten, soziale Beziehungen aufnehmen)*	☐	☐	☐	☐
Bedeutende Lebensbereiche *(z. B. Arbeit und Beschäftigung, Erziehung und Bildung, wirtschaftliche Eigenständigkeit, sich beschäftigen können)*	☐	☐	☐	☐
Gemeinschaftsleben und soziales Leben *(z. B. am Gemeinschaftsleben beteiligen, Erholung und Freizeit)*	☐	☐	☐	☐

G. Lebensumstände/Kontextfaktoren

1. Rehabilitationsrelevante umwelt- und personbezogene Faktoren

(z. B. allein / mit Familie lebend, in Alten-/Pflegeeinrichtung lebend, Konflikte, Pflege oder Tod eines Familienangehörigen, Unterstützung(-sbedarf), sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, Mehrfachbelastung, mangelndes Selbstmanagement, soziale Isolation, Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen)

Verbindliches Muster

2. Risikofaktoren oder Gefährdung durch

☐ Bewegungsmangel Fehlhaltung BMI _____ ☐ Fehl-/Mangelernährung ☐ Medikamente ☐ Nikotin

☐ Sonstiges *z.B. Suchtmittel* _____

III. Angaben zur Rehabilitationsfähigkeit

Der/die Patient/in verfügt über ausreichende physische und psychische Belastbarkeit ☐ ja ☐ nein

Ausfertigung für den Vertragsarzt

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

Freigabe 23.03.2022

61 Teil D

IV. Rehabilitationsziele

A. Rehabilitationsziele in Bezug auf die oben genannten Schädigungen und Beeinträchtigungen

B. Rehabilitationsziele aus Sicht der Patientin / des Patienten, sofern ABWEICHEND von den zuvor genannten

V. Rehabilitationsprognose

Unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs und der individuell vorhandenen bzw. förderungsfähigen Ressourcen besteht eine **positive Prognose** für die unter IV. A. und IV. B. benannten Rehabilitationsziele

☐ ja ☐ eingeschränkt, hinsichtlich ***(z. B. Erreichbarkeit in der vorgesehenen Zeit, aktueller Motivationslage)***

VI. Zuweisungsempfehlungen

A. Empfohlene Rehabilitationsform

☐ ambulant ☐ ambulant-mobil ☐ stationär

☐ Mütter-Leistung ☐ Väter-Leistung ☐ als Mutter-Kind-Leistung ☐ als Vater-Kind-Leistung

B. Inhaltliche Schwerpunkte/Indikationen ***(z.B. orthopädisch, kardiologisch, geriatrisch, Kinder-Jugend)***

☐ geriatr. Rehabilitation

C. Weitere Bemerkungen/Begründungen ***(u. a. Anforderungen an die Einrichtung z. B. Barrierefreiheit auch für körper-, seh-, hör- oder sprachbehinderte Menschen, klimatische Anforderungen, Allergiefaktoren, besondere Kostformen, fremdsprachliche Betreuung, besondere Therapieformen)***

☐ pflegende/r Angehörige/r ☐ andere

VII. Sonstige Angaben

Die beantragte Leistung ist vor Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von 4 Jahren medizinisch notwendig aufgrund

☐ neuer Indikation ☐ Verschlimmerung bei gleicher Indikation

☐ **Die zeitweise Entlastung und Distanzierung vom sozialen Umfeld ist nötig**

☐ **Im Falle einer ambulanten Rehabilitation ist die häusliche Versorgung gesichert**

Reisefähigkeit

☐ öffentliche Verkehrsmittel ☐ PKW erforderlich ☐ Begleitperson erforderlich

Versorgung der/des Pflegebedürftigen während der stationären Rehabilitation der/des pflegenden Angehörigen

☐ Mitaufnahme der/des Pflegebedürftigen in derselben Einrichtung gewünscht
(sofern medizinische Gründe dagegen sprechen, sind diese unter Sonstiges anzugeben)

☐ Koordination der Versorgung der/des Pflegebedürftigen in einer anderen Einrichtung durch Krankenkasse/Pflegekasse gewünscht

Sonstiges ***(z. B. besondere Hinweise zur Reisefähigkeit, Schwangerschaft)*** **/ Rückruf erbeten unter**

Verbindliches Muster

Ausfertigung für die Krankenkasse

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

Freigabe 23.03.2022

61 Teil D

IV. Rehabilitationsziele

A. Rehabilitationsziele in Bezug auf die oben genannten Schädigungen und Beeinträchtigungen

B. Rehabilitationsziele aus Sicht der Patientin / des Patienten, sofern ABWEICHEND von den zuvor genannten

V. Rehabilitationsprognose

Unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs und der individuell vorhandenen bzw. förderungsfähigen Ressourcen besteht eine **positive Prognose** für die unter IV. A. und IV. B. benannten Rehabilitationsziele

☐ ja ☐ eingeschränkt, hinsichtlich ***(z. B. Erreichbarkeit in der vorgesehenen Zeit, aktueller Motivationslage)***

VI. Zuweisungsempfehlungen

A. Empfohlene Rehabilitationsform

☐ ambulant ☐ ambulant-mobil ☐ stationär

☐ Mütter-Leistung ☐ Väter-Leistung ☐ als Mutter-Kind-Leistung ☐ als Vater-Kind-Leistung

B. Inhaltliche Schwerpunkte/Indikationen ***(z.B. orthopädisch, kardiologisch, geriatrisch, Kinder-Jugend)***

☐ geriatr. Rehabilitation

C. Weitere Bemerkungen/Begründungen ***(u. a. Anforderungen an die Einrichtung z. B. Barrierefreiheit auch für körper-, seh-, hör- oder sprachbehinderte Menschen, klimatische Anforderungen, Allergiefaktoren, besondere Kostformen, fremdsprachliche Betreuung, besondere Therapieformen)***

☐ pflegende/r Angehörige/r ☐ andere

VII. Sonstige Angaben

Die beantragte Leistung ist vor Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von 4 Jahren medizinisch notwendig aufgrund

☐ neuer Indikation ☐ Verschlimmerung bei gleicher Indikation

☐ **Die zeitweise Entlastung und Distanzierung vom sozialen Umfeld ist nötig**

☐ **Im Falle einer ambulanten Rehabilitation ist die häusliche Versorgung gesichert**

Reisefähigkeit

☐ öffentliche Verkehrsmittel ☐ PKW erforderlich ☐ Begleitperson erforderlich

Versorgung der/des Pflegebedürftigen während der stationären Rehabilitation der/des pflegenden Angehörigen

☐ Mitaufnahme der/des Pflegebedürftigen in derselben Einrichtung gewünscht
(sofern medizinische Gründe dagegen sprechen, sind diese unter Sonstiges anzugeben)

☐ Koordination der Versorgung der/des Pflegebedürftigen in einer anderen Einrichtung durch Krankenkasse/Pflegekasse gewünscht

Sonstiges ***(z. B. besondere Hinweise zur Reisefähigkeit, Schwangerschaft)*** **/ Rückruf erbeten unter**

Verbindliches Muster

Ausfertigung für den Vertragsarzt

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

Freigabe 23.03.2022

61 Teil E

VIII. Inhalt der abgegebenen Einwilligungserklärungen und Angaben der/des Versicherten

A. Erteilte Einwillligungserklärungen

1. Einwilligung der/des Versicherten zur Übermittlung der gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes an die verordnende Vertragsärztin / den verordnenden Vertragsarzt wurde erteilt.

☐ ja ☐ nein

2. Einwilligung der/des Versicherten zur Übermittlung der Leistungsentscheidung der Krankenkasse an Angehörige und Vertrauenspersonen sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen wurde erteilt.

☐ ja ☐ nein

Hinweis zur Datenübermittlung und zum Widerrufsrecht

Die Einwilligung in die Übermittlung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V. Die erteilten Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei Ihrer Krankenkasse oder der verordnenden Ärztin / dem verordnenden Arzt widerrufen werden.

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung (Teil B-E) ist die Nr. 01611 EBM berechnungsfähig

Datum

T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

B. Angaben der/des Versicherten

Vor der Weiterleitung des Vordrucks an die Krankenkasse von der/dem Versicherten auszufüllen, sofern die Einwilligung unter VIII. A. 2. erteilt wurde.

Angaben durch die Versicherte/den Versicherten zu Angehörigen und Vertrauenspersonen sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen, denen die Leistungsentscheidung durch die Krankenkasse übermittelt werden soll (VIII. A. 2.).

Name, Vorname

PLZ | Ort | Straße, Haus-Nr.

Name, Vorname

PLZ | Ort | Straße, Haus-Nr.

Name, Vorname

PLZ | Ort | Straße, Haus-Nr.

Datum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Unterschrift der oder des Versicherten (des gesetzlichen Vertreters, des Betreuers, des Bevollmächtigten)

Ausfertigung für die Krankenkasse

Name, Vorname des Versicherten	Freigabe 23.03.2022 Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

61 Teil E

VIII. Inhalt der abgegebenen Einwilligungserklärungen und Angaben der/des Versicherten

A. Erteilte Einwilligungserklärungen

1. Einwilligung der/des Versicherten zur Übermittlung der gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes an die verordnende Vertragsärztin / den verordnenden Vertragsarzt wurde erteilt.

☐ ja ☐ nein

2. Einwilligung der/des Versicherten zur Übermittlung der Leistungsentscheidung der Krankenkasse an Angehörige und Vertrauenspersonen sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen wurde erteilt.

☐ ja ☐ nein

Hinweis zur Datenübermittlung und zum Widerrufsrecht

Die Einwilligung in die Übermittlung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V. Die erteilten Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei Ihrer Krankenkasse oder der verordnenden Ärztin / dem verordnenden Arzt widerrufen werden.

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung (Teil B-E) ist die Nr. 01611 EBM berechnungsfähig

Datum T T M M J J

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

B. Angaben der/des Versicherten

Vor der Weiterleitung des Vordrucks an die Krankenkasse von der/dem Versicherten auszufüllen, sofern die Einwilligung unter VIII. A. 2. erteilt wurde.

Angaben durch die Versicherte/den Versicherten zu Angehörigen und Vertrauenspersonen sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen, denen die Leistungsentscheidung durch die Krankenkasse übermittelt werden soll (VIII. A. 2.).

Name, Vorname

PLZ ☐☐☐☐☐ Ort _____ Straße, Haus-Nr. _____

Name, Vorname

PLZ ☐☐☐☐☐ Ort _____ Straße, Haus-Nr. _____

Name, Vorname

PLZ ☐☐☐☐☐ Ort _____ Straße, Haus-Nr. _____

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Unterschrift der oder des Versicherten (des gesetzlichen Vertreters, des Betreuers, des Bevollmächtigten)

Ausfertigung für den Vertragsarzt

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Freigabe 10.05.2022

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Ergebnis der Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials gemäß AKI-Richtlinie des G-BA

62A

Maßnahmen zur Prüfung des Potenzials oder der Therapieoptimierung
(z.B. Spontanatmungstest durchgeführt, NIV-Versuch, FEES, Entblockungsversuche)

Befunde der ärztlichen Schluckdiagnostik

Ergebnis der Erhebung

Potenzial liegt vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Empfehlung zur Beatmungsentwöhnung bzw. Dekanülierung in folgenden spezialisierten Einrichtungen

geplanter Termin M M J J

Potenzial kann perspektivisch vorliegen ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

erforderliche vorbereitende Maßnahmen ***(bspw. Lagerungstherapie, Mobilisation, Physiotherapie, Logopädie, Atmungstherapie)***

Potenzial liegt nicht vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Begründung

Maßnahmen der Therapieoptimierung ***(ggf. Einweisung in spezialisierte Einrichtung)***
sowie weitere Hinweise zum klinischen Status

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

☐ Eine Erhebung zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität ist nicht mehr angezeigt.

Weitere Erläuterungen

Ergebnis der Erhebung festgestellt am T T M M J J

Erneute Erhebung geplant am T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für die Krankenkasse

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Freigabe 10.05.2022

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Ergebnis der Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials gemäß AKI-Richtlinie des G-BA

62A

Maßnahmen zur Prüfung des Potenzials oder der Therapieoptimierung
(z.B. Spontanatmungstest durchgeführt, NIV-Versuch, FEES, Entblockungsversuche)

Befunde der ärztlichen Schluckdiagnostik

Ergebnis der Erhebung

Potenzial liegt vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Empfehlung zur Beatmungsentwöhnung bzw. Dekanülierung in folgenden spezialisierten Einrichtungen

geplanter Termin M M J J

Potenzial kann perspektivisch vorliegen ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

erforderliche vorbereitende Maßnahmen ***(bspw. Lagerungstherapie, Mobilisation, Physiotherapie, Logopädie, Atmungstherapie)***

Potenzial liegt nicht vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Begründung

Maßnahmen der Therapieoptimierung ***(ggf. Einweisung in spezialisierte Einrichtung)***
sowie weitere Hinweise zum klinischen Status

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

☐ Eine Erhebung zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität ist nicht mehr angezeigt.

Weitere Erläuterungen

Ergebnis der Erhebung festgestellt am
T T M M J J

Erneute Erhebung geplant am
T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

~~Freigabe 10.05.2022~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Ergebnis der Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials gemäß AKI-Richtlinie des G-BA

62A

Maßnahmen zur Prüfung des Potenzials oder der Therapieoptimierung
(z.B. Spontanatmungstest durchgeführt, NIV-Versuch, FEES, Entblockungsversuche)

Befunde der ärztlichen Schluckdiagnostik

Ergebnis der Erhebung

Potenzial liegt vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Empfehlung zur Beatmungsentwöhnung bzw. Dekanülierung in folgenden spezialisierten Einrichtungen

geplanter Termin M M J J

Potenzial kann perspektivisch vorliegen ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

erforderliche vorbereitende Maßnahmen ***(bspw. Lagerungstherapie, Mobilisation, Physiotherapie, Logopädie, Atmungstherapie)***

Potenzial liegt nicht vor ☐ zur Beatmungsentwöhnung ☐ zur Dekanülierung

Begründung

Maßnahmen der Therapieoptimierung ***(ggf. Einweisung in spezialisierte Einrichtung)***
sowie weitere Hinweise zum klinischen Status

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

☐ Eine Erhebung zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität ist nicht mehr angezeigt.

Weitere Erläuterungen

Ergebnis der Erhebung festgestellt am T T M M J J

Erneute Erhebung geplant am T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für den potenzialerhebenden Arzt

Freigabe 30.05.2022

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung außerklinischer Intensivpflege

62B

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

vom T T M M J J bis T T M M J J

Voraussichtliches Entlassdatum ***(nur durch Krankenhaus anzugeben)*** T T M M J J

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung ☐ Vorabinformation aus dem Krankenhaus vor Entlassung gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 AKI-Richtlinie ***(fakultativ I bis III)*** ☐ Unfall

I. Klinischer Status

☐ **Beatmung, seit** T T M M J J

Beatmungsform	Beatmungsdauer	Spontanatmungszeit
☐ invasiv	☐☐ Stunden pro Tag	☐☐ Stunden pro Tag
☐ nicht invasiv, Maskentyp	☐☐ Stunden pro Nacht	☐☐ Stunden pro Nacht

☐ **Tracheostoma, seit** T T M M J J

Trachealkanüle	Entblockungszeiten
☐ geblockt ☐ ungeblockt ☐ Sprechventil	

☐ **Endotracheale Absaugpflicht** durchschnittliche tgl. Absaugfrequenz ☐ zu regelmäßigen Zeiten ☐ zu unregelmäßigen Zeiten

☐ **Sonstige vitale Funktionseinschränkungen**, Art und Häufigkeit

☐ **Bewusstseinsstörung**, Art

Mitwirkung bei AKI	Kommunikation Verständigung	Orientierung vorhanden, zu	Mobilität vorhanden		Orale Ernährung
☐ uneingeschränkt	☐ uneingeschränkt	☐ Ort	☐ uneingeschränkt	☐ Nackengriff	☐ nein
☐ eingeschränkt	☐ eingeschränkt	☐ Zeit	☐ bis an die Bettkante in den Rollstuhl	☐ Schürzengriff	☐ ja
☐ nicht möglich	☐ nicht möglich	☐ Person	☐ stehfähig, gehfähig	☐ Faustschluss	☐ teilweise
		☐ Situation	☐ immobil	☐ Pinzettengriff	
		☐ nicht vorhanden			

II. Erforderlicher Leistungsumfang der AKI ☐☐ Stunden je Tag

III. Weitere Hinweise

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

Erhebungen nach Muster 62A zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität

☐ sind weiterhin angezeigt ☐ sind nicht mehr angezeigt ☐ werden durch den Patienten nicht mehr gewünscht

Weitere Erläuterungen

Konsilpartner bei nicht beatmungspflichtigen oder nicht trachealkanülierten Versicherten, wenn die Verordnung durch eine nicht auf die Erkrankung spezialisierte Fachärztin oder Facharzt erfolgt

Sonstige Hinweise ***(z.B. zu Kommunikation, Mitwirkung, Mobilität, Ernährung)***

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel/Unterschrift des verordnenden Arztes

Ausfertigung für die Krankenkasse (rückseitig der Antrag des Versicherten)

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

Freigabe 30.05.2022

Antrag des Versicherten auf außerklinische Intensivpflege *(Nicht auszufüllen bei Vorabinformation aus Krankenhaus)*

Ich beantrage außerklinische Intensivpflege für die Zeit vom T T M M J J bis T T M M J J

- ☐ in meinem Haushalt
- ☐ in einer vollstationären Pflegeeinrichtung
- ☐ im Haushalt einer sonstigen Person
- ☐ in einer Schule, Kindergarten
- ☐ in einer betreuten Wohnform
- ☐ in einer Werkstatt für behinderte Menschen
- ☐ in einer Wohneinheit
- ☐ in einer sonstigen Einrichtung

Leistungsort

Name des Leistungortes

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

Wird von den An- und Zugehörigen im Verordnungszeitraum die Übernahme von Leistungen angestrebt?

☐ Ja, es wird die Übernahme folgender Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege durch An- und Zugehörige angestrebt:

☐ Nein, es wird keine Übernahme von Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege durch An- und Zugehörige angestrebt.

An der Versorgung beteiligte An- und Zugehörige

Name

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

Datum T T M M J J

Bevollmächtigte/r bzw. Betreuer/in

Name

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

Telefonnummer ***(freiwillige Angabe)***

Unterschrift des Versicherten oder des gesetzlichen Vertreters

Angaben des Leistungserbringers nach § 132l Abs. 5 SGB V *(Nicht auszufüllen bei Vorabinformation aus Krankenhaus)*

Die außerklinische Intensivpflege wird täglich in der Zeit

vom T T M M J J bis T T M M J J im Umfang von ☐☐ Stunden erbracht.

Die außerklinische Intensivpflege wird durchgeführt von einem zugelassenen Leistungserbringer ***(§ 132l Abs. 5 SGB V)***

Name

Straße, Haus-Nr

PLZ Ort

Institutionskennzeichen

Ansprechpartner (Name)

Telefonnummer Fax-Nr.

E-Mail-Adresse

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel / Unterschrift des Leistungserbringers

~~Freigabe 30.05.2022~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung außerklinischer Intensivpflege

62B

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

vom T T M M J J bis T T M M J J

Voraussichtliches Entlassdatum ***(nur durch Krankenhaus anzugeben)*** T T M M J J

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung ☐ Vorabinformation aus dem Krankenhaus vor Entlassung gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 AKI-Richtlinie ***(fakultativ I bis III)*** ☐ Unfall

I. Klinischer Status

☐ **Beatmung, seit** T T M M J J

Beatmungsform	Beatmungsdauer	Spontanatmungszeit
☐ invasiv	☐☐ Stunden pro Tag	☐☐ Stunden pro Tag
☐ nicht invasiv, Maskentyp _____	☐☐ Stunden pro Nacht	☐☐ Stunden pro Nacht

☐ **Tracheostoma, seit** T T M M J J

Trachealkanüle	Entblockungszeiten
☐ geblockt ☐ ungeblockt ☐ Sprechventil	_____

☐ **Endotracheale Absaugpflicht** durchschnittliche tgl. Absaugfrequenz _____ ☐ zu regelmäßigen Zeiten ☐ zu unregelmäßigen Zeiten

☐ **Sonstige vitale Funktionseinschränkungen**, Art und Häufigkeit _____

☐ **Bewusstseinsstörung**, Art _____

Mitwirkung bei AKI	Kommunikation Verständigung	Orientierung vorhanden, zu	Mobilität vorhanden		Orale Ernährung
☐ uneingeschränkt	☐ uneingeschränkt	☐ Ort	☐ uneingeschränkt	☐ Nackengriff	☐ nein
☐ eingeschränkt	☐ eingeschränkt	☐ Zeit	☐ bis an die Bettkante in den Rollstuhl	☐ Schürzengriff	☐ ja
☐ nicht möglich	☐ nicht möglich	☐ Person	☐ stehfähig, gehfähig	☐ Faustschluss	☐ teilweise
		☐ Situation	☐ immobil	☐ Pinzettengriff	
		☐ nicht vorhanden			

II. Erforderlicher Leistungsumfang der AKI

☐☐ Stunden je Tag

III. Weitere Hinweise

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

Erhebungen nach Muster 62A zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität

☐ sind weiterhin angezeigt ☐ sind nicht mehr angezeigt ☐ werden durch den Patienten nicht mehr gewünscht

Weitere Erläuterungen

Konsilpartner bei nicht beatmungspflichtigen oder nicht trachealkanülierten Versicherten, wenn die Verordnung durch eine nicht auf die Erkrankung spezialisierte Fachärztin oder Facharzt erfolgt

Sonstige Hinweise ***(z.B. zu Kommunikation, Mitwirkung, Mobilität, Ernährung)***

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel/Unterschrift des verordnenden Arztes

Ausfertigung für den Leistungserbringer nach § 132l

Freigabe 30.05.2022

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung außerklinischer Intensivpflege

62B

Verordnungsrelevante Diagnose(n) ***(ICD-10-Code)***

vom T T M M J J bis T T M M J J

Voraussichtliches Entlassdatum ***(nur durch Krankenhaus anzugeben)*** T T M M J J

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung ☐ Vorabinformation aus dem Krankenhaus vor Entlassung gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 AKI-Richtlinie ***(fakultativ I bis III)*** ☐ Unfall

I. Klinischer Status

☐ **Beatmung, seit** T T M M J J

Beatmungsform	Beatmungsdauer	Spontanatmungszeit
☐ invasiv	☐☐ Stunden pro Tag	☐☐ Stunden pro Tag
☐ nicht invasiv, Maskentyp _____	☐☐ Stunden pro Nacht	☐☐ Stunden pro Nacht

☐ **Tracheostoma, seit** T T M M J J

Trachealkanüle	Entblockungszeiten
☐ geblockt ☐ ungeblockt ☐ Sprechventil	_____

☐ **Endotracheale Absaugpflicht** durchschnittliche tgl. Absaugfrequenz _____ ☐ zu regelmäßigen Zeiten ☐ zu unregelmäßigen Zeiten

☐ **Sonstige vitale Funktionseinschränkungen**, Art und Häufigkeit _____

☐ **Bewusstseinsstörung**, Art _____

Mitwirkung bei AKI	Kommunikation Verständigung	Orientierung vorhanden, zu	Mobilität vorhanden		Orale Ernährung
☐ uneingeschränkt	☐ uneingeschränkt	☐ Ort	☐ uneingeschränkt	☐ Nackengriff	☐ nein
☐ eingeschränkt	☐ eingeschränkt	☐ Zeit	☐ bis an die Bettkante in den Rollstuhl	☐ Schürzengriff	☐ ja
☐ nicht möglich	☐ nicht möglich	☐ Person	☐ stehfähig, gehfähig	☐ Faustschluss	☐ teilweise
		☐ Situation	☐ immobil	☐ Pinzettengriff	
		☐ nicht vorhanden			

II. Erforderlicher Leistungsumfang der AKI

☐☐ Stunden je Tag

III. Weitere Hinweise

☐ Innerhalb von mindestens zwei Jahren wurde zweimal in Folge im Rahmen einer unmittelbar persönlichen Erhebung festgestellt, dass keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung besteht und eine Entwöhnung oder Dekanülierung dauerhaft nicht möglich ist. Eine regelmäßige Erhebung des Beatmungsentwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials ist nicht mehr angezeigt.

Erhebungen nach Muster 62A zum Zwecke der Therapieoptimierung und zur Verbesserung der Lebensqualität

☐ sind weiterhin angezeigt ☐ sind nicht mehr angezeigt ☐ werden durch den Patienten nicht mehr gewünscht

Weitere Erläuterungen

Konsilpartner bei nicht beatmungspflichtigen oder nicht trachealkanülierten Versicherten, wenn die Verordnung durch eine nicht auf die Erkrankung spezialisierte Fachärztin oder Facharzt erfolgt

Sonstige Hinweise ***(z.B. zu Kommunikation, Mitwirkung, Mobilität, Ernährung)***

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel/Unterschrift des verordnenden Arztes

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Freigabe 30.05.2022

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Behandlungsplan

62C

Bedarfsmedikamente für AKI

Notfallmanagement

Therapieziele

MRE-Besiedelung ☐ nein ☐ ja, folgender Keim

Maßnahmen der Heilmitteltherapie zur Unterstützung der Therapieziele im Rahmen der AKI ☐ Logopädie ☐ Physiotherapie ☐ Ergotherapie

Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege

☐ **Benennung der zu erfassenden und zu bewertenden Vitalparameter**

☐ **Tracheostoma/Trachealkanülenmanagement**

Tracheotomie	Trachealkanüle	Befeuchtung
☐ dilatativ ☐ chirurgisch	Hersteller Innendurchmesser in mm ☐☐,☐	☐ passiv ☐ aktiv

☐ **Sekretmanagement**

Absauggerät	Inhalationsgerät
☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐	☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐ Medikament/ Substanz

☐ **Dysphagiemanagement**

☐ **Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes**
Beatmungsgeräteinstellungen

☐ **Sauerstoffinsufflation** ☐ ja ☐ nein ☐ Notfallversorgung

mit Beatmung	unter Spontanatmung	Mobilität
Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐

☐ **Spezielle Hygienemaßnahmen**

Sonstige eingeleitete Maßnahmen (einschließlich weiterer Maßnahmen der AKI)

Verbindliches Muster

Medizinische Behandlungspflege *(ggf. Beiblatt nutzen)*

Leistung	Häufigkeit tgl.	Häufigkeit wtl.	Häufigkeit mtl.	Dauer vom	Dauer bis

Name des Arztes / der Ärztin

ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für die Krankenkasse

~~Freigabe 30.05.2022~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Behandlungsplan

62C

Bedarfsmedikamente für AKI

Notfallmanagement

Therapieziele

MRE-Besiedelung ☐ nein ☐ ja, folgender Keim

Maßnahmen der Heilmitteltherapie zur Unterstützung der Therapieziele im Rahmen der AKI ☐ Logopädie ☐ Physiotherapie ☐ Ergotherapie

Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege

☐ **Benennung der zu erfassenden und zu bewertenden Vitalparameter**

☐ **Tracheostoma/Trachealkanülenmanagement**

Tracheotomie	Trachealkanüle	Befeuchtung
☐ dilatativ ☐ chirurgisch	Hersteller ____ Innendurchmesser in mm ☐☐,☐	☐ passiv ☐ aktiv

☐ **Sekretmanagement**

Absauggerät	Inhalationsgerät
☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐	☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐ Medikament/ Substanz ____

☐ **Dysphagiemanagement**

☐ **Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes**
Beatmungsgeräteinstellungen

☐ **Sauerstoffinsufflation** ☐ ja ☐ nein ☐ Notfallversorgung

mit Beatmung	unter Spontanatmung	Mobilität
Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐

☐ **Spezielle Hygienemaßnahmen**

Sonstige eingeleitete Maßnahmen (einschließlich weiterer Maßnahmen der AKI)

Verbindliches Muster

Medizinische Behandlungspflege *(ggf. Beiblatt nutzen)*

Leistung	Häufigkeit tgl.	Häufigkeit wtl.	Häufigkeit mtl.	Dauer vom	Dauer bis

Name des Arztes / der Ärztin

ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für den Leistungserbringer nach § 132l

~~Freigabe 30.05.2022~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Behandlungsplan

62C

Bedarfsmedikamente für AKI

Notfallmanagement

Therapieziele

MRE-Besiedelung ☐ nein ☐ ja, folgender Keim

Maßnahmen der Heilmitteltherapie zur Unterstützung der Therapieziele im Rahmen der AKI ☐ Logopädie ☐ Physiotherapie ☐ Ergotherapie

Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege

☐ **Benennung der zu erfassenden und zu bewertenden Vitalparameter**

☐ **Tracheostoma/Trachealkanülenmanagement**

Tracheotomie	Trachealkanüle	Befeuchtung
☐ dilatativ ☐ chirurgisch	Hersteller ____ Innendurchmesser in mm ☐☐,☐	☐ passiv ☐ aktiv

☐ **Sekretmanagement**

Absauggerät	Inhalationsgerät
☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐	☐ ja ☐ nein Häufigkeit pro Tag ☐☐ Medikament/ Substanz ____

☐ **Dysphagiemanagement**

☐ **Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes**
Beatmungsgeräteinstellungen

☐ **Sauerstoffinsufflation** ☐ ja ☐ nein ☐ Notfallversorgung

mit Beatmung	unter Spontanatmung	Mobilität
Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐	Flow ☐☐ l/min Dauer h/tgl. ☐☐

☐ **Spezielle Hygienemaßnahmen**

Sonstige eingeleitete Maßnahmen (einschließlich weiterer Maßnahmen der AKI)

Verbindliches Muster

Medizinische Behandlungspflege *(ggf. Beiblatt nutzen)*

Leistung	Häufigkeit tgl.	Häufigkeit wtl.	Häufigkeit mtl.	Dauer vom	Dauer bis

Name des Arztes / der Ärztin

ärztliche Unterschrift

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (SAPV)

63

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung

☐ Unfall Unfallfolgen

vom T T M M J J bis T T M M J J

Verordnungsrelevante Diagnose(n) (ICD-10; ggf. Organmanifestationen)

Die Krankheit ist nicht heilbar, sie ist fortschreitend und weit fortgeschritten.

Komplexes Symptomgeschehen

☐ ausgeprägte Schmerzsymptomatik

☐ ausgeprägte urogenitale Symptomatik

☐ ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik

☐ ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik

☐ ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore

☐ ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische Symptomatik

☐ sonstiges komplexes Symptomgeschehen

Nähere Beschreibung des komplexen Symptomgeschehens und des besonderen Versorgungsbedarfs zur Begründung, warum spezialisierte ambulante Palliativversorgung notwendig ist (z. B. therapierefraktäre Schmerzen, Ruhedyspnoe / Erstickungsanfälle, nicht beherrschbares Erbrechen / Durchfälle)

Aktuelle Medikation (ggf. einschließlich BtM)

Folgende Maßnahmen sind notwendig

☐ Beratung

☐ a. des behandelnden Arztes

☐ b. der behandelnden Pflegefachkraft

☐ c. des Patienten / der Angehörigen

☐ Koordination der Palliativversorgung

mit folgender inhaltlicher Ausrichtung (Gegenstand, Häufigkeit, evtl. Beratung für Sonstige)

☐ Additiv unterstützende Teilversorgung

☐ Vollständige Versorgung

Nähere Angaben zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für die Krankenkasse

Für die Erstverordnung ist die Kostenpauschale 01425, für die Folgeverordnung die Kostenpauschale 01426 berechnungsfähig.

Antrag des Versicherten

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung wird wie vom behandelnden Arzt verordnet beantragt.

Datenschutzhinweis (§ 67a Abs. 3 SGB X): Damit wir Ihren Antrag auf SAPV-Leistungen bearbeiten können, ist Ihr Mitwirken nach § 60 SGB I erforderlich. Ihre Daten sind im vorliegenden Falle aufgrund § 37b SGB V i. V. m. § 92 Abs. 1 SGB V zu erheben.

Datum T T M M J J

Unterschrift des Versicherten / Vertretungsberechtigten

Angaben des Leistungserbringers für die SAPV

Die verordnete spezialisierte ambulante Palliativversorgung wird für den Zeitraum vom T T M M J J bis T T M M J J erbracht.

Name des Leistungserbringers / ggf. Stempel

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) / ggf. Stempel

Institutionskennzeichen des Leistungserbringers

Ansprechpartner (Name)

Telefonnummer

Fax-Nummer

E-Mail

Datum T T M M J J

Stempel / Unterschrift des SAPV-Leistungserbringers

Genehmigung der Krankenkasse

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung wird nach den vereinbarten Sätzen

☐ entsprechend der Verordnung übernommen

☐ in folgendem Umfang übernommen

Die Genehmigung der Krankenkasse ist der Abrechnung beizufügen. Endet die Notwendigkeit vor Ablauf des angegebenen Zeitraums, so erlischt damit auch die Kostenverpflichtung.

Sollte die SAPV über den letzten Bewilligungstag hinaus erforderlich sein, so ist **rechtzeitig vor Ablauf** des genehmigten Zeitraums eine erneute Verordnung bei der Krankenkasse einzureichen.

Auszufüllen, soweit von Seiten der Krankenkasse Bedarf besteht

Name, Vorname des Versicherten

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort

Versichertennummer

Geburtsdatum T T M M J J J J

Datum T T M M J J

~~Freigabe 01.09.2014~~

Verbindliches Muster

Stempel / Unterschrift der Krankenkasse

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (SAPV)

63

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung

☐ Unfall Unfallfolgen

vom T T M M J J bis T T M M J J

Verordnungsrelevante Diagnose(n) (ICD-10; ggf. Organmanifestationen)

Die Krankheit ist nicht heilbar, sie ist fortschreitend und weit fortgeschritten.

Komplexes Symptomgeschehen

☐ ausgeprägte Schmerzsymptomatik

☐ ausgeprägte urogenitale Symptomatik

☐ ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik

☐ ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik

☐ ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore

☐ ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische Symptomatik

☐ sonstiges komplexes Symptomgeschehen

Nähere Beschreibung des komplexen Symptomgeschehens und des besonderen Versorgungsbedarfs zur Begründung, warum spezialisierte ambulante Palliativversorgung notwendig ist (z. B. therapierefraktäre Schmerzen, Ruhedyspnoe / Erstickungsanfälle, nicht beherrschbares Erbrechen / Durchfälle)

Aktuelle Medikation (ggf. einschließlich BtM)

Folgende Maßnahmen sind notwendig

☐ Beratung

☐ a. des behandelnden Arztes

☐ b. der behandelnden Pflegefachkraft

☐ c. des Patienten / der Angehörigen

☐ Koordination der Palliativversorgung

mit folgender inhaltlicher Ausrichtung (Gegenstand, Häufigkeit, evtl. Beratung für Sonstige)

☐ Additiv unterstützende Teilversorgung

☐ Vollständige Versorgung

Nähere Angaben zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für die Erstverordnung ist die Kostenpauschale 01425, für die Folgeverordnung die Kostenpauschale 01426 berechnungsfähig.

Ausfertigung für den spezialisierten Leistungserbringer

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (SAPV)

63

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung

☐ Unfall Unfallfolgen

vom T T M M J J bis T T M M J J

Verordnungsrelevante Diagnose(n) (ICD-10; ggf. Organmanifestationen)

Die Krankheit ist nicht heilbar, sie ist fortschreitend und weit fortgeschritten.

Komplexes Symptomgeschehen

☐ ausgeprägte Schmerzsymptomatik

☐ ausgeprägte urogenitale Symptomatik

☐ ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik

☐ ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik

☐ ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore

☐ ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische Symptomatik

☐ sonstiges komplexes Symptomgeschehen

Nähere Beschreibung des komplexen Symptomgeschehens und des besonderen Versorgungsbedarfs zur Begründung, warum spezialisierte ambulante Palliativversorgung notwendig ist (z. B. therapierefraktäre Schmerzen, Ruhedyspnoe / Erstickungsanfälle, nicht beherrschbares Erbrechen / Durchfälle)

Aktuelle Medikation (ggf. einschließlich BtM)

Folgende Maßnahmen sind notwendig

☐ Beratung

☐ a. des behandelnden Arztes

☐ b. der behandelnden Pflegefachkraft

☐ c. des Patienten / der Angehörigen

☐ Koordination der Palliativversorgung

mit folgender inhaltlicher Ausrichtung (Gegenstand, Häufigkeit, evtl. Beratung für Sonstige)

☐ Additiv unterstützende Teilversorgung

☐ Vollständige Versorgung

Nähere Angaben zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Für die Erstverordnung ist die Kostenpauschale 01425, für die Folgeverordnung die Kostenpauschale 01426 berechnungsfähig.

Ausfertigung für den spezialisierten Leistungserbringer – der Abrechnung beizufügen

~~Freigabe 01.09.2014~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (SAPV)

63

☐ Erst-verordnung ☐ Folge-verordnung

☐ Unfall Unfallfolgen

vom T T M M J J bis T T M M J J

Verordnungsrelevante Diagnose(n) (ICD-10; ggf. Organmanifestationen)

Die Krankheit ist nicht heilbar, sie ist fortschreitend und weit fortgeschritten.

Komplexes Symptomgeschehen

☐ ausgeprägte Schmerzsymptomatik

☐ ausgeprägte urogenitale Symptomatik

☐ ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik

☐ ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik

☐ ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore

☐ ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische Symptomatik

☐ sonstiges komplexes Symptomgeschehen

Nähere Beschreibung des komplexen Symptomgeschehens und des besonderen Versorgungsbedarfs zur Begründung, warum spezialisierte ambulante Palliativversorgung notwendig ist (z. B. therapierefraktäre Schmerzen, Ruhedyspnoe / Erstickungsanfälle, nicht beherrschbares Erbrechen / Durchfälle)

Aktuelle Medikation (ggf. einschließlich BtM)

Folgende Maßnahmen sind notwendig

☐ Beratung

☐ a. des behandelnden Arztes

☐ b. der behandelnden Pflegefachkraft

☐ c. des Patienten / der Angehörigen

☐ Koordination der Palliativversorgung

mit folgender inhaltlicher Ausrichtung (Gegenstand, Häufigkeit, evtl. Beratung für Sonstige)

☐ Additiv unterstützende Teilversorgung

☐ Vollständige Versorgung

Nähere Angaben zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung für den verordnenden Arzt

Für die Erstverordnung ist die Kostenpauschale 01425, für die Folgeverordnung die Kostenpauschale 01426 berechnungsfähig.

Freigabe 29.03.2018

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Verbindliches Muster

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Verordnung medizinischer Vorsorge für Mütter oder Väter gemäß § 24 SGB V

64 Teil A

Ausreichende physische und psychische Belastbarkeit für eine Vorsorgeleistung ist gegeben

I. Vorsorgerelevante Gesundheitsstörungen/Erkrankungen

A. Vorsorgerelevante Gesundheitsstörungen einschließlich Risikofaktoren

(Beschwerden, die in absehbarer Zeit zu einer Erkrankung führen können)

B. Vorsorgerelevante Erkrankungen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung

Diagnoseschlüssel ICD-10-GM

II. Vorsorgebedürftigkeit

A. Kurze Angaben zur Anamnese

B. Vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe in Folge der unter I. B. genannten Erkrankungen

(beispielsweise Entscheidungen treffen, mit Stress umgehen, auf die eigene Gesundheit und Ernährung achten, Hausarbeiten erledigen, häusliches Leben organisieren, Familien-/soziale Beziehungen pflegen, einer Beschäftigung sowie eigenen Interessen und Hobbies nachgehen)

C. Kontextfaktoren, die für die mütter-/väterspezifische Problemkonstellation relevant sind

- ☐ Mehrfachbelastung durch Beruf/Familie
- ☐ fehlende Anerkennung der Mutter-/Vaterrolle
- ☐ Tod des Partners/ naher Angehöriger
- ☐ beeinträchtigte Mutter-/Vater-Kind Beziehung
- ☐ mangelnde Unterstützung bei der Kindererziehung
- ☐ Partner-/ Eheprobleme/ Trennung vom Partner
- ☐ Teenager-schwangerschaft
- ☐ Überforderungssituation am Arbeitsplatz/in der Schule
- ☐ Erziehungs-schwierigkeiten
- ☐ Pflege von Familienangehörigen
- ☐ soziale Isolation
- ☐ sprachliche Verständigungs-schwierigkeiten
- ☐ Schwierigkeiten bei der Problembewältigung (Alltagsprobleme)
- ☐ finanzielle Sorgen
- ☐ besonders belastende/ unregelmäßige Arbeitszeiten
- ☐ mangelnde Grundkompetenzen im Zusammenhang mit den Aufgaben einer Mutter/eines Vaters
- ☐ ständiger Zeitdruck
- ☐ drohender Arbeitsplatzverlust/ Arbeitslosigkeit
- ☐ erhöhter Betreuungsaufwand durch häufig oder chronisch erkrankte, verhaltensauffällige oder behinderte Kinder, frühgeborene Kinder, Mehrlingsgeburten
- ☐ allein erziehend
- ☐ nicht gleichberechtigte Stellung der Frau / des Mannes in der Familie

andere Kontextfaktoren; ggf. nähere Erläuterungen

Ausfertigung für die Krankenkasse

Krankenkasse bzw. Kostenträger

~~Freigabe 29.03.2018~~

Name, Vorname des Versicherten

Verbindliches Muster

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Verordnung medizinischer Vorsorge für Mütter oder Väter gemäß § 24 SGB V

64 Teil A

Ausreichende physische und psychische Belastbarkeit für eine Vorsorgeleistung ist gegeben

I. Vorsorgerelevante Gesundheitsstörungen/Erkrankungen

A. Vorsorgerelevante Gesundheitsstörungen einschließlich Risikofaktoren

(Beschwerden, die in absehbarer Zeit zu einer Erkrankung führen können)

B. Vorsorgerelevante Erkrankungen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung

Diagnoseschlüssel ICD-10-GM

II. Vorsorgebedürftigkeit

A. Kurze Angaben zur Anamnese

B. Vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe in Folge der unter I. B. genannten Erkrankungen

(beispielsweise Entscheidungen treffen, mit Stress umgehen, auf die eigene Gesundheit und Ernährung achten, Hausarbeiten erledigen, häusliches Leben organisieren, Familien-/soziale Beziehungen pflegen, einer Beschäftigung sowie eigenen Interessen und Hobbies nachgehen)

C. Kontextfaktoren, die für die mütter-/väterspezifische Problemkonstellation relevant sind

- ☐ Mehrfachbelastung durch Beruf/Familie
- ☐ fehlende Anerkennung der Mutter-/Vaterrolle
- ☐ Tod des Partners/ naher Angehöriger
- ☐ beeinträchtigte Mutter-/Vater-Kind Beziehung
- ☐ mangelnde Unterstützung bei der Kindererziehung
- ☐ Partner-/ Eheprobleme/ Trennung vom Partner
- ☐ Teenager-schwangerschaft
- ☐ Überforderungssituation am Arbeitsplatz/in der Schule
- ☐ Erziehungs-schwierigkeiten
- ☐ Pflege von Familienangehörigen
- ☐ soziale Isolation
- ☐ sprachliche Verständigungs-schwierigkeiten
- ☐ Schwierigkeiten bei der Problembewältigung (Alltagsprobleme)
- ☐ finanzielle Sorgen
- ☐ besonders belastende/ unregelmäßige Arbeitszeiten
- ☐ mangelnde Grundkompetenzen im Zusammenhang mit den Aufgaben einer Mutter/eines Vaters
- ☐ ständiger Zeitdruck
- ☐ drohender Arbeitsplatzverlust/ Arbeitslosigkeit
- ☐ erhöhter Betreuungsaufwand durch häufig oder chronisch erkrankte, verhaltensauffällige oder behinderte Kinder, frühgeborene Kinder, Mehrlingsgeburten
- ☐ allein erziehend
- ☐ nicht gleichberechtigte Stellung der Frau / des Mannes in der Familie

andere Kontextfaktoren; ggf. nähere Erläuterungen

Ausfertigung für den Arzt

Muster 64 Ab (10.2018)

Bitte vor der Beschriftung der Formulare diese Fußleiste abreißen und die 2 Einzelsätze voneinander trennen

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

64 Teil B

III. Krankenbehandlung und andere Maßnahmen

A. Bisherige ärztliche/psychotherapeutische Interventionen einschließlich Arzneimittel-/Heilmitteltherapie

☐ Heilmittel zur Erreichung des Behandlungsziels nicht ausreichend / nicht zielführend

B. Bisherige andere Maßnahmen ***(z. B. Patientenschulungen, Rehabilitationssport/Funktionstraining, Wahrnehmung von Beratungs- und Selbsthilfeangeboten, Angaben zu Maßnahmen in eigener Regie)***

IV. Vorsorgeziele

Vorsorgeziele in Bezug auf die genannten Gesundheitsstörungen/Erkrankungen, Kontext- und Risikofaktoren

V. Zuweisungsempfehlungen

A. Empfohlene Leistungsform: Medizinische Vorsorge für Mütter oder Väter nach § 24 SGB V als

☐ Mütter-Leistung ☐ Väter-Leistung ☐ Mutter-Kind-Leistung ☐ Vater-Kind-Leistung

B. Angaben zu Kindern, die mit aufgenommen werden sollen

	Name des Kindes	Geburtsdatum	s. Attest Kind insbes. bei Behandlungs-notwendigkeit*	Belastete Mutter-/ Vater-Kind-Beziehung	Psychosoziale Gründe/ Betreuung notwendig
1.		T T M M J J	☐	☐	☐
2.		T T M M J J	☐	☐	☐
3.		T T M M J J	☐	☐	☐

* ***Das „Ärztliche Attest Kind“ (Muster 65) nur ausfüllen bei Behandlungsbedürftigkeit, chronischer Erkrankung, Behinderung oder bei psychischen Auffälligkeiten des Kindes (ggf. durch den behandelnden Kinderarzt)***

VI. Sonstige Angaben

A. Anforderungen an die Einrichtung ***(z. B. Klima, Barrierefreiheit, Allergenarmut, besondere Kostformen, fremdsprachliche Angebote, spezialisierte Therapieangebote, konfessionelle Ausrichtung, Einrichtung nur für Frauen, Hinweise für mitaufzunehmende Kinder)***

☐ ja, folgende

B. Die Leistung ist vor Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von 4 Jahren dringend medizinisch notwendig

☐ ja, Erläuterung

C. Sonstiges ***(z. B. besondere Hinweise zur Reisefähigkeit, ggf. vorliegende Schwangerschaft)***

D. Rückruf erbeten unter Telefon-Nummer

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung ist die Nr. 01624 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für die Krankenkasse

Ausstellungsdatum T T M M J J

~~Freigabe 29.03.2018~~

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Name, Vorname des Versicherten	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.

64 Teil B

III. Krankenbehandlung und andere Maßnahmen

A. Bisherige ärztliche/psychotherapeutische Interventionen einschließlich Arzneimittel-/Heilmitteltherapie

☐ Heilmittel zur Erreichung des Behandlungsziels nicht ausreichend / nicht zielführend

B. Bisherige andere Maßnahmen *(z. B. Patientenschulungen, Rehabilitationssport/Funktionstraining, Wahrnehmung von Beratungs- und Selbsthilfeangeboten, Angaben zu Maßnahmen in eigener Regie)*

IV. Vorsorgeziele

Vorsorgeziele in Bezug auf die genannten Gesundheitsstörungen/Erkrankungen, Kontext- und Risikofaktoren

V. Zuweisungsempfehlungen

A. Empfohlene Leistungsform: Medizinische Vorsorge für Mütter oder Väter nach § 24 SGB V als

☐ Mütter-Leistung ☐ Väter-Leistung ☐ Mutter-Kind-Leistung ☐ Vater-Kind-Leistung

B. Angaben zu Kindern, die mit aufgenommen werden sollen

	Name des Kindes	Geburtsdatum	s. Attest Kind insbes. bei Behandlungs-notwendigkeit*	Belastete Mutter-/ Vater-Kind-Beziehung	Psychosoziale Gründe/ Betreuung notwendig
1.		T T M M J J	☐	☐	☐
2.		T T M M J J	☐	☐	☐
3.		T T M M J J	☐	☐	☐

* *Das „Ärztliche Attest Kind“ (Muster 65) nur ausfüllen bei Behandlungsbedürftigkeit, chronischer Erkrankung, Behinderung oder bei psychischen Auffälligkeiten des Kindes (ggf. durch den behandelnden Kinderarzt)*

VI. Sonstige Angaben

A. Anforderungen an die Einrichtung *(z. B. Klima, Barrierefreiheit, Allergenarmut, besondere Kostformen, fremdsprachliche Angebote, spezialisierte Therapieangebote, konfessionelle Ausrichtung, Einrichtung nur für Frauen, Hinweise für mitaufzunehmende Kinder)*

☐ ja, folgende

B. Die Leistung ist vor Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von 4 Jahren dringend medizinisch notwendig

☐ ja, Erläuterung

C. Sonstiges *(z. B. besondere Hinweise zur Reisefähigkeit, ggf. vorliegende Schwangerschaft)*

D. Rückruf erbeten unter Telefon-Nummer

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung ist die Nr. 01624 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für den Arzt

Ausstellungsdatum T T M M J J

~~Freigabe 29.03.2018~~

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Freigabe 29.03.2018

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Ärztliches Attest Kind

65

zur Verordnung einer medizinischen Vorsorge / Rehabilitation für Mütter oder Väter gemäß §§ 24, 41 SGB V

I. Kurze Angaben zur Anamnese

II. Vorliegende Gesundheitsprobleme

A. Gesundheitsstörungen *(Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes durch z. B. Atemwegsinfekte über das alterstypische Maß hinaus, Übergewicht, psychische Auffälligkeiten)*

B. Erkrankungen

Diagnoseschlüssel ICD-10-GM

C. Weitere relevante Informationen *(z. B. Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen)*

III. Bisherige Krankenbehandlung und andere Maßnahmen

IV. Empfohlene Interventionen während der Maßnahme

V. Hinweise für die Zuweisung

A. Anforderungen an die Einrichtung *(z. B. Klima, Barrierefreiheit, Allergenarmut, besondere Kostformen, spezialisierte Therapie- und Betreuungsangebote, konfessionelle Ausrichtung)*

☐ ja, folgende

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für die Krankenkasse

Ausstellungsdatum

T T M M J J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

~~Freigabe 29.03.2018~~

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status

Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Ärztliches Attest Kind

65

zur Verordnung einer medizinischen Vorsorge / Rehabilitation für Mütter oder Väter gemäß §§ 24, 41 SGB V

I. Kurze Angaben zur Anamnese

II. Vorliegende Gesundheitsprobleme

A. Gesundheitsstörungen ***(Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes durch z. B. Atemwegsinfekte über das alterstypische Maß hinaus, Übergewicht, psychische Auffälligkeiten)***

B. Erkrankungen

Diagnoseschlüssel ICD-10-GM

C. Weitere relevante Informationen ***(z. B. Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen)***

III. Bisherige Krankenbehandlung und andere Maßnahmen

IV. Empfohlene Interventionen während der Maßnahme

V. Hinweise für die Zuweisung

A. Anforderungen an die Einrichtung ***(z. B. Klima, Barrierefreiheit, Allergenarmut, besondere Kostformen, spezialisierte Therapie- und Betreuungsangebote, konfessionelle Ausrichtung)***

☐ ja, folgende

Für das Ausstellen der ärztlichen Verordnung ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig

Ausfertigung für den Arzt

Ausstellungsdatum

T	T	M	M	J	J

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Freigabe 01.09.2014

Behandlungsplan

70

für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V sowie der „Richtlinien über künstliche Befruchtung“ des Gemeinsamen Bundesausschusses für die hier genannten Ehegatten

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Das folgende Personalfeld ist an dieser Stelle nicht bedruckbar. Bitte von Hand ausfüllen oder Personalfeldaufkleber verwenden (auch auf dem Durchschlag).

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

I Indikation(en)

gemäß Nummern 11.1-11.5 der Richtlinien über künstliche Befruchtung

II Geplante Behandlungsmaßnahme

- ☐ Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
- ☐ Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
- ☐ In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
- ☐ Intratubarer-Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
- ☐ Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)

Anzahl und Art bereits erfolgter Behandlungen (gemäß Nr. 10.1-10.5)

III Kostenschätzung

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse. Auflistung der Positionen ggf. auf separatem Beiblatt. Kostenschätzungen sind als durchschnittliche Kostenspanne in Euro anzugeben.

a Kosten für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen) ♀ / ♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstunden-bedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen (Euro)	♀ / ♂

Ort | Datum (T T M M J J)

b Kosten pro Zyklusfall (ohne einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen)

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen) ♀ / ♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Medikamenten-kosten (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstunden-bedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme pro Zyklusfall (Euro)	♀ / ♂

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

IV Genehmigung durch die Krankenkasse(n)

Die auf die jeweils zulässige Höchstzahl anzurechnenden Vorbehandlungen sind zu berücksichtigen und verringern die Anzahl der genehmigten Zyklen.

Bei einer Genehmigung für 3 IVF- oder ICSI-Zyklen steht der 3. IVF- oder ICSI-Zyklus unter dem Vorbehalt, dass in einem von 2 Behandlungszyklen eine Befruchtung stattgefunden hat. Bei Inseminationen im Spontanzyklus kann die Genehmigung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt werden.

Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive Medikamentenkosten, siehe Abschnitt III b) Eigenanteil des Patienten. Eine abschließende Berechnung der Gesamtkosten kann – u. a. in Abhängigkeit des vertraglich vereinbarten Punktwertes in Cent bzw. Euro – erst nach Beendigung der Behandlung erfolgen.

Bei Änderung der Behandlungsmethode (siehe Abschnitt II) sowie spätestens nach Ablauf eines Jahres seit der Genehmigung ist ein neuer Behandlungsplan vorzulegen.

Original nach Genehmigung zum Verbleib beim Vertragsarzt

Der Behandlungs-/Kostenplan wird

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♀

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort | Datum (T T M M J J)

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♂

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort | Datum (T T M M J J)

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Das folgende Personalfeld ist an dieser Stelle nicht bedruckbar. Bitte von Hand ausfüllen oder Personalfeldaufkleber verwenden.

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Behandlungsplan

70

für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V sowie der „Richtlinien über künstliche Befruchtung" des Gemeinsamen Bundesausschusses für die hier genannten Ehegatten

I Indikation(en)

gemäß Nummern 11.1-11.5 der Richtlinien über künstliche Befruchtung

II Geplante Behandlungsmaßnahme

- ☐ Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
- ☐ Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
- ☐ In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
- ☐ Intratubarer-Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
- ☐ Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)

Anzahl und Art bereits erfolgter Behandlungen (gemäß Nr. 10.1-10.5)

III Kostenschätzung

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse. Auflistung der Positionen ggf. auf separatem Beiblatt. Kostenschätzungen sind als durchschnittliche Kostenspanne in Euro anzugeben.

a Kosten für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

♀

♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstunden-bedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen (Euro)	♀ / ♂

Ort

Datum T T M M J J

b Kosten pro Zyklusfall (ohne einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen)

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

♀

♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Medikamenten-kosten (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstunden-bedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme pro Zyklusfall (Euro)	♀ / ♂

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

IV Genehmigung durch die Krankenkasse(n)

Die auf die jeweils zulässige Höchstzahl anzurechnenden Vorbehandlungen sind zu berücksichtigen und verringern die Anzahl der genehmigten Zyklen.

Bei einer Genehmigung für 3 IVF- oder ICSI-Zyklen steht der 3. IVF- oder ICSI-Zyklus unter dem Vorbehalt, dass in einem von 2 Behandlungszyklen eine Befruchtung stattgefunden hat. Bei Inseminationen im Spontanzyklus kann die Genehmigung für bis zu 8 in Folge geplante Zyklen erteilt werden.

Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive Medikamentenkosten, siehe Abschnitt III b) Eigenanteil des Patienten. Eine abschließende Berechnung der Gesamtkosten kann – u. a. in Abhängigkeit des vertraglich vereinbarten Punktwertes in Cent bzw. Euro – erst nach Beendigung der Behandlung erfolgen.

Bei Änderung der Behandlungsmethode (siehe Abschnitt II) sowie spätestens nach Ablauf eines Jahres seit der Genehmigung ist ein neuer Behandlungsplan vorzulegen.

Durchschlag für die Kassenärztliche Vereinigung

Der Behandlungs-/Kostenplan wird

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♀

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort

Datum T T M M J J

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♂

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Das folgende Personalfeld ist an dieser Stelle nicht bedruckbar. Bitte von Hand ausfüllen oder Personalfeldaufkleber verwenden (auch auf dem Durchschlag).

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Folge-Behandlungsplan 70A

zum Behandlungsplan vom T T M M J J

für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V sowie der „Richtlinien über künstliche Befruchtung" des Gemeinsamen Bundesausschusses für die hier genannten Ehegatten

I Indikation(en)

gemäß Nummern 11.1-11.5 der Richtlinien über künstliche Befruchtung

II Geplante Behandlungsmaßnahme

- ☐ Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
- ☐ Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
- ☐ In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
- ☐ Intratubarer-Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
- ☐ Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)

Anzahl und Art bereits ohne Eintritt einer klinisch nachgewiesenen Schwangerschaft erfolgter Behandlungen (gemäß Nr. 10.1-10.5)

III Kostenschätzung

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse. Auflistung der Positionen ggf. auf separatem Beiblatt. Kostenschätzungen sind als durchschnittliche Kostenspanne in Euro anzugeben.

a Kosten für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstundenbedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen (Euro)	♀ / ♂

Ort | Datum T T M M J J

b Kosten pro Zyklusfall (ohne einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen)

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Medikamentenkosten (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstundenbedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme pro Zyklusfall (Euro)	♀ / ♂

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

IV Genehmigung durch die Krankenkasse(n)

Die auf die jeweils zulässige Höchstzahl anzurechnenden Vorbehandlungen sind zu berücksichtigen und verringern die Anzahl der genehmigten Zyklen.

Werden mehrere Zyklen genehmigt, erlischt die Genehmigung, sobald die Gesamtzahl der Behandlungen (einschließlich Vorbehandlungen), die nicht zu einer klinisch nachgewiesenen Schwangerschaft geführt haben, die jeweils zulässige Höchstzahl erreicht hat.

Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive Medikamentenkosten, siehe Abschnitt III b) Eigenanteil des Patienten. Eine abschließende Berechnung der Gesamtkosten kann – u. a. in Abhängigkeit des vertraglich vereinbarten Punktwertes in Cent bzw. Euro – erst nach Beendigung der Behandlung erfolgen.

Spätestens nach Ablauf eines Jahres seit der Genehmigung sowie bei Änderung der Behandlungsmethode ist ein neuer Folge-Behandlungsplan vorzulegen.

Ausfertigung nach Genehmigung zum Verbleib beim Vertragsarzt

Der Behandlungs-/Kostenplan wird

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♀

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort | Datum T T M M J J

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♂

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort | Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

Freigabe 01.09.2014

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Das folgende Personalfeld ist an dieser Stelle nicht bedruckbar. Bitte von Hand ausfüllen oder Personalfeldaufkleber verwenden (auch auf dem Durchschlag).

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Folge-Behandlungsplan 70A

zum Behandlungsplan vom T T M M J J

für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V sowie der „Richtlinien über künstliche Befruchtung" des Gemeinsamen Bundesausschusses für die hier genannten Ehegatten

I Indikation(en)

gemäß Nummern 11.1-11.5 der Richtlinien über künstliche Befruchtung

II Geplante Behandlungsmaßnahme

- ☐ Insemination im Spontanzyklus (gemäß Nr. 10.1)
- ☐ Insemination nach hormoneller Stimulation (gemäß Nr. 10.2)
- ☐ In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (gemäß Nr. 10.3)
- ☐ Intratubarer-Gameten-Transfer (gemäß Nr. 10.4)
- ☐ Intracytoplasmatische Spermieninjektion (gemäß Nr. 10.5)

Anzahl und Art bereits ohne Eintritt einer klinisch nachgewiesenen Schwangerschaft erfolgter Behandlungen (gemäß Nr. 10.1-10.5)

III Kostenschätzung

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Änderung der diagnostischen und therapeutischen Einzelfallerfordernisse. Auflistung der Positionen ggf. auf separatem Beiblatt. Kostenschätzungen sind als durchschnittliche Kostenspanne in Euro anzugeben.

a Kosten für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

♀

♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstundenbedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme für einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen (Euro)	♀ / ♂

Ort

Datum T T M M J J

b Kosten pro Zyklusfall (ohne einmalig im Reproduktionsfall anfallende Leistungen)

Ärztliche Behandlung (EBM-Positionen)

♀

♂

Summe Ärztliche Behandlung (Euro)	♀ / ♂
Medikamentenkosten (Euro)	♀ / ♂
Sachkosten und Sprechstundenbedarf (Euro)	♀ / ♂
Gesamtsumme pro Zyklusfall (Euro)	♀ / ♂

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

IV Genehmigung durch die Krankenkasse(n)

Die auf die jeweils zulässige Höchstzahl anzurechnenden Vorbehandlungen sind zu berücksichtigen und verringern die Anzahl der genehmigten Zyklen.

Werden mehrere Zyklen genehmigt, erlischt die Genehmigung, sobald die Gesamtzahl der Behandlungen (einschließlich Vorbehandlungen), die nicht zu einer klinisch nachgewiesenen Schwangerschaft geführt haben, die jeweils zulässige Höchstzahl erreicht hat.

Nach § 27a SGB V sind 50% der entstehenden Kosten (inklusive Medikamentenkosten, siehe Abschnitt III b) Eigenanteil des Patienten. Eine abschließende Berechnung der Gesamtkosten kann – u. a. in Abhängigkeit des vertraglich vereinbarten Punktwertes in Cent bzw. Euro – erst nach Beendigung der Behandlung erfolgen.

Spätestens nach Ablauf eines Jahres seit der Genehmigung sowie bei Änderung der Behandlungsmethode ist ein neuer Folge-Behandlungsplan vorzulegen.

Ausfertigung für die Kassenärztliche Vereinigung

Der Behandlungs-/Kostenplan wird

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♀

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort

Datum T T M M J J

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

für maximal _____ Zyklen/Zyklus **genehmigt** ♂

☐ **nicht genehmigt** (separate Begründung anbei)

Ort

Datum T T M M J J

Verbindliches Muster

Stempel und Unterschrift der Krankenkasse, **auch auf dem Durchschlag**

Krankenkasse

Name

Vorname

Geburtsdatum T T M M J J

Anschrift

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Nachweis der Anspruchsberechtigung 85

bei Ruhen des Anspruchs gemäß § 16 Absatz 3a SGB V

gültig für Quartal Q J J

Dieser Nachweis gilt im Rahmen der Kostenübernahme durch die unterzeichnende Krankenkasse für die/den oben genannte(n) Versicherte(n) bei Früherkennungsuntersuchungen gemäß §§ 25 und 26 SGB V und bei Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen/Schmerzzustände sowie Schwangerschaft/Mutterschaft erforderlich sind.

Ausstellungsdatum T T M M J J

Freigabe ~~01.09.2014~~

verbindliches Muster

Stempel / Unterschrift der Krankenkasse

Weiterleitungsbogen für angeforderte Informationen an den MD

86

wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie den Weiterleitungsbogen als erste Seite im Briefumschlag für Ihre Antwort!

Freigabe 13.04.2026

Deutsche Post
ANTWORT

Verbindliches Muster

Aktenzeichen Mitteilungsmanagement (MiMa)

Krankenkasse

Name der Krankenkasse

Straße

PLZ Ort

Leistungsbereich

Ansprechpartner Krankenkasse

Vorname, Name

Telefon

Fax

E-Mail

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übermitteln wir Ihnen die für den Versicherten von der Krankenkasse angeforderten Informationen in Kopie.

Daten des Versicherten

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ Ort

KV-Nummer

Aktenzeichen Krankenkasse